KOSDAQ | 제약과생물공학

이뮨온시아 (424870)

면역항암 신약, 상용화에 속도를 더하다

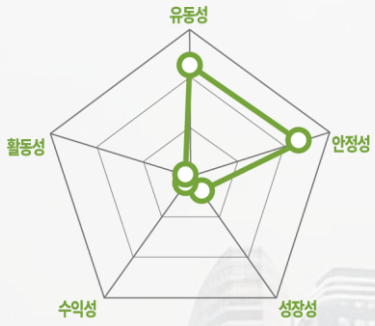
체크포인트

- 이뮨온시아는 2016년 유한양행과 미국 소렌토테라퓨틱스가 공동 설립한 PD-L1·CD47 항체 기반 면역항암제 신약개발기업
- IMC-001, NK/T세포림프종 임상 2상 완료 및 적응증 확대: PD-L1 표적 항체 IMC-001은 재발성·불응성 NK/T세포림프종 대상 임상 2상에서 객관적반응률(ORR) 79%, 완전반응률(CR) 63%를 기록함. 2026년 1월 국내 희귀의약품 지정을 획득하였으며, TMB-High 고형암 대상 임상 2상도 진행 중임. 국내 상용화와 해외 기술이전을 병행하는 전략 추진 중
- IMC-002, 고형암 임상 성과 기반 글로벌 기술이전 추진: CD47 표적 항체 IMC-002는 간세포암 대상 병용요법에서 ORR 30%, 바이오마커 선별군에서 ORR 60%를 기록함. 삼중음성유방암 대상 임상 1b상에서도 ORR 25%를 확인하였으며, 후속 임상 데이터 확보를 통한 글로벌 기술이전 추진 중
- 818억원 유상증자로 IMC-001 상용화 준비 본격화: 2026년 5월 약 818억원의 유상증자를 완료하였으며, 글로벌 CDMO 론자와 생산 협력 체계를 구축하고 유한양행의 국내 유통망을 활용해 2029년 품목허가 신청, 2030년 국내 출시를 목표로 하고 있음. 향후 IMC-001의 상용화 진전과 IMC-001·002의 해외 기술이전 성과가 기업가치 재평가의 주요 요인으로 작용할 전망

주가 및 주요이벤트

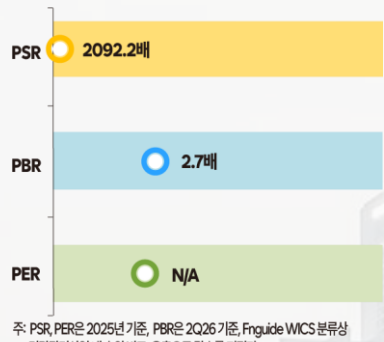


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 건강관리산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 건강관리산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

이뮨온시아 (424870)

KOSDAQ
제약과생물공학

Analyst 박선영 sypark@kirs.or.kr
RA 정수현 sh.jeong@kirs.or.kr

PD-L1·CD47 기반 면역항암제 신약개발기업

이뮨온시아는 2016년 유한양행과 미국 소렌토테라퓨틱스가 공동 설립한 항체 기반 면역항암제 신약개발기업으로, 2025년 5월 코스닥시장에 상장. 주요 파이프라인은 PD-L1 표적 항체 IMC-001과 CD47 표적 항체 IMC-002, 두 항체를 기반으로 한 이중항체 IMC-201도 개발 중. 핵심 파이프라인인 IMC-001은 국내 상용화와 해외 기술이전을 병행하는 이원화 전략을 추진 중임

IMC-001 임상 2상 완료, IMC-002 고형암 임상 성과 확보

IMC-001은 재발성·불응성 NK/T세포림프종 대상 임상 2상을 완료, 객관적반응률(ORR) 79%, 완전반응률(CR) 63%, 2년 전체생존율(OS) 78%를 기록함. 2026년 1월 국내 희귀의약품 지정을 획득하였으며, TMB-High 고형암 대상 임상 2상도 진행 중임. IMC-002는 간세포암·삼중음성유방암 등 고형암 대상 임상 1b상을 진행 중이며, 간세포암에서 ORR 30%, 바이오마커 선별군에서 ORR 60%를 기록함. 삼중음성유방암에서도 ORR 25%, 질병통제율(DCR) 75%를 확인하였으며, 이를 기반으로 글로벌 기술이전을 추진 중임. 이중항체 IMC-201은 비임상 개발 단계임

818억원 자금 확보로 IMC-001 상용화 준비 본격화

이뮨온시아는 IMC-001의 2029년 품목허가 신청과 2030년 국내 출시를 목표로 상용화 준비를 본격화하고 있음. 2026년 3월 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업 론자(Lonza)와 개발·생산 협력 계약을 체결하였으며, 국내 판매·유통은 최대주주인 유한양행과 협력할 계획. 특히 2026년 5월 약 818억원 규모의 유상증자 완료, 이 중 약 790억원을 IMC-001의 제조·품질관리(CMC) 관련 비용에 투입할 예정. 이를 통해 기존 임상개발 중심의 사업구조에서 신약 상용화를 병행하는 단계로 전환하고 있음

Forecast earnings & Valuation

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	77	1	7	1	0
YoY(%)	21,413.6	-98.6	495.0	-83.0	-83.0
영업이익(억원)	-151	-118	-126	-280	-301
OP 마진(%)	-194.9	-10,724.5	-1,924.8	-25,182.0	-159,285.3
지배주주순이익(억원)	-35	89	-57	-274	-290
EPS(원)	-47	119	-74	-346	-335
YoY(%)	적지	흑전	적전	적지	적지
PER(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSR(배)	N/A	N/A	N/A	8,913.9	13,462.5
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(배)	N/A	N/A	N/A	35.2	3.3
ROE(%)	6.2	-20.5	77.0	-114.4	-52.9
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (10/23)		2,925원
52주 최고가		14,797원
52주 최저가		2,445원
KOSDAQ (10/23)		751.69p
자본금		371억원
시가총액		2,674억원
액면가		500원
발행주식수		91백만주
일평균 거래량 (60일)		60만주
일평균 거래액 (60일)		20억원
외국인지분율		1.12%
주요주주	유한양행 외 1 인	56.61%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-5.0	-59.4	-48.7
상대주가	6.7	-36.5	-40.5

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '영업이익 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

기업 개요

1 회사 개요

이뮨온시아는 항체 기반 면역항암제 연구개발기업

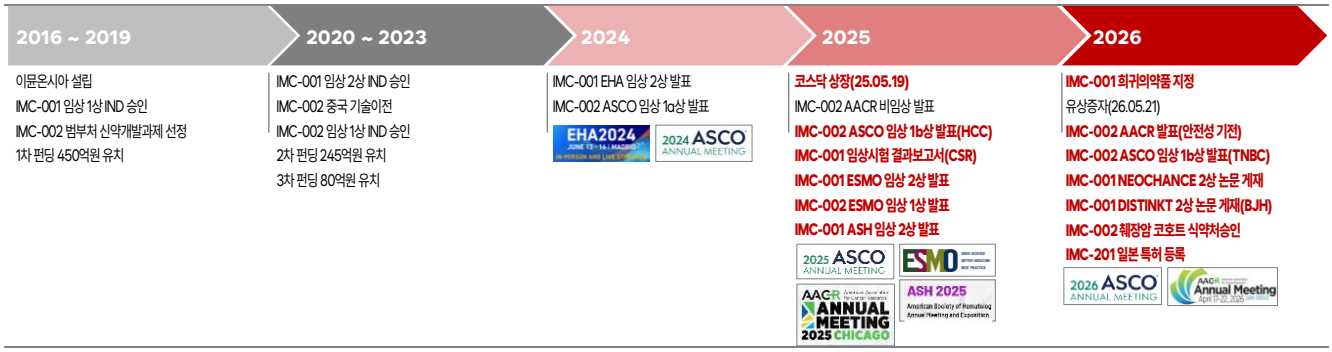
이뮨온시아는 2016년 9월 유한양행과 미국 소렌토테라퓨틱스(Sorrento Therapeutics)가 공동 설립한 항체 기반 면역항암제 연구개발기업으로, 2025년 5월 기술특례를 통해 코스닥시장에 상장하였다. 인체의 면역체계를 활용해 암세포를 제거하는 항체 신약개발에 주력하고 있으며, T세포와 대식세포를 각각 표적으로 하는 단일항체를 기반으로 이중항체 등 후속 파이프라인을 확장하고 있다. 주요 파이프라인은 PD-L1 항체인 IMC-001과 CD47 항체인 IMC-002로, IMC-001은 NK/T세포림프종을 대상으로 임상 2상을 완료했으며, TMB-High 고형암을 대상으로는 임상 2상을 진행중이다. IMC-002는 간암·삼중음성유방암·담도암 등 고형암을 대상으로 임상 1b상을 진행하고 있으며, 2026년 8월 췌장암 대상 코호트 추가 승인을 받았다. 이외에도 두 항체의 작용기전을 결합한 이중항체 IMC-201을 비임상 단계에서 개발 중이다.

동사는 2018년 IMC-001의 국내 임상 1상 승인을 시작으로 신약개발을 본격화하였으며, 2020년 IMC-001의 NK/T세포림프종 대상 임상 2상과 IMC-002의 미국 임상 1상 승인을 획득하였다. 2021년에는 중국 3D메디슨(3D Medicines)에 IMC-002의 중국 지역 개발·상업화 권리를 기술이전하며 첫 기술이전 성과를 확보하였다. 이후 2024년 기술성평가에서 A·BBB 등급을 획득하고 2025년 코스닥시장에 상장하였다. 최근에는 IMC-001의 국내 상용화 준비를 본격화하고 있으며, 2026년 1월 국내 희귀의약품 지정에 이어 3월 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업인 론자(Lonza)와 개발·생산 협력계약을 체결하였다.

동사의 기본 사업모델은 신약 후보물질의 임상개발을 통해 기술적 가치를 높인 후 글로벌 제약사에 기술이전하는 구조다. 주요 수익원은 기술이전 계약금(Upfront), 개발 단계별 마일스톤(Milestone), 상업화 이후 로열티(Royalty) 등으로 구성된다. 다만, 핵심 파이프라인인 IMC-001은 해외 기술이전과 국내 상용화를 병행하는 이원화 전략을 추진하고 있다. 동사는 당초 2027년부터 추진할 예정이었던 IMC-001의 상용화 준비를 2025년 8월 이사회 결의를 통해 2년 앞당겼으며, 현재 2029년 품목허가 신청과 2030년 국내 출시를 목표로 하고 있다. 국내에서는 동사가 임상개발과 품목허가를 담당하고, 독점 유통 파트너인 유한양행이 약가·급여 등재 및 영업·마케팅 등을 수행하는 역할 분담 구조다. 해외에서는 기존 기술이전 수익 외에 임상용 의약품 및 완제의약품 공급을 통한 추가 매출 확보도 추진하고 있다.

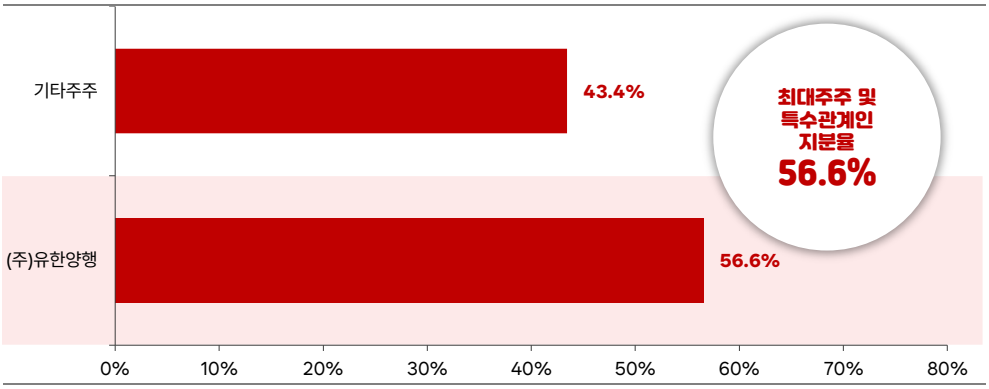
최대주주는 유한양행으로, 2026년 6월 말 기준 지분 56.6%를 보유하고 있다. 설립 당시 합작 파트너였던 소렌토테라퓨틱스의 파산 이후 2023년 유한양행이 소렌토 보유지분을 인수하면서 지분율은 35.0%에서 67.7%로 상승하였으며, 2025년 말에는 65.9%를 기록하였다. 이후 2026년 5월 약 818억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시하면서 유한양행의 지분율은 56.6%로 낮아졌다. 이번 유상증자는 IMC-001의 국내 상용화 준비를 위한 자금조달로, 조달금액 중 약 790억원을 원료·완제의약품의 생산공정 개발 및 검증, 품질관리 등 제조·품질관리(CMC) 관련 비용에 투입할 계획이다. 동사는 이를 통해 기존 기술이전 중심의 수익구조에서 자체 신약의 국내 상용화를 병행하는 사업구조로 전환을 추진하고 있다.

회사 연혁



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

주주현황(2026년 6월말 기준)



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 핵심 기술 및 주요 파이프라인

T세포와 대식세포를 표적으로 하는 항체 개발 전략

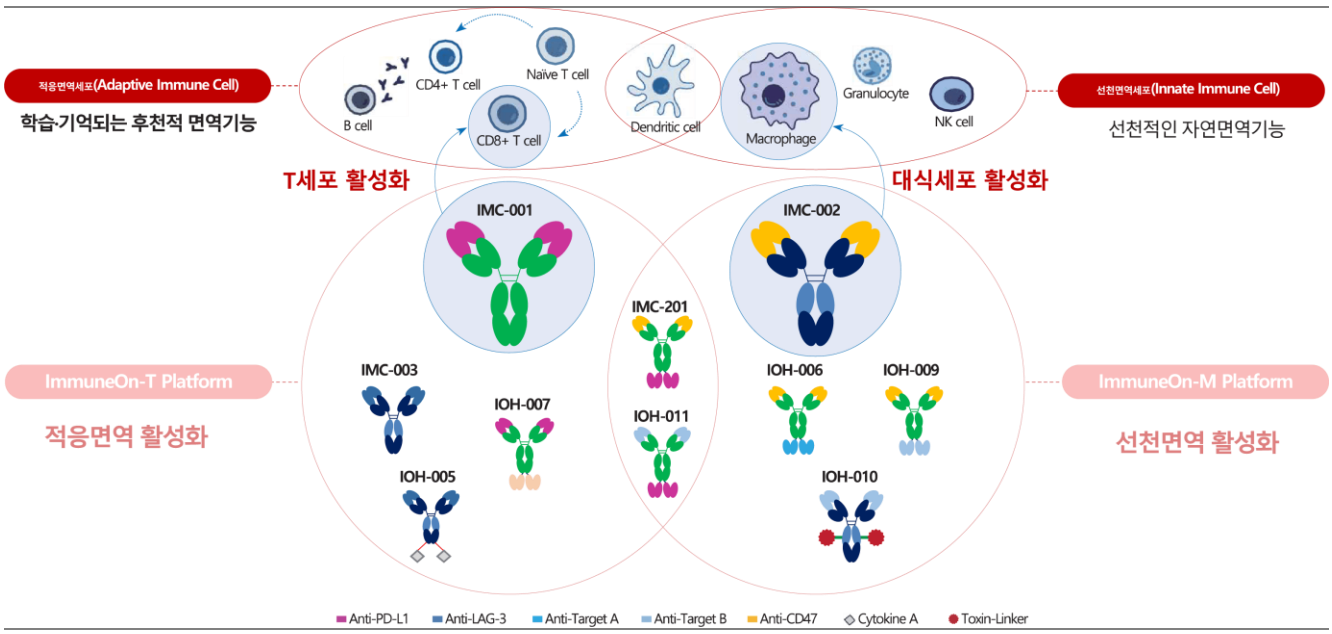
이뮨온시아는 인체의 면역체계를 활용해 암세포를 제거하는 항체 기반 면역항암제를 개발하고 있다. 일반적인 세포독성항암제가 빠르게 증식하는 암세포를 직접 공격하는 반면, 면역항암제는 암세포의 면역회피 기전을 차단하거나 면역세포의 항암 기능을 활성화하는 방식으로 작용한다. 특히 암세포는 면역세포의 공격을 피하기 위해 다양한 면역관문(Immune Checkpoint)을 활용하는데, 이를 차단해 면역세포가 암세포를 다시 공격하도록 유도하는 것이 면역관문억제제의 기본 원리다.

인체의 면역체계는 크게 선천면역(Innate Immunity)과 적응면역(Adaptive Immunity)으로 구분된다. 선천면역은 대식세포(Macrophage), 자연살해세포(NK세포) 등이 외부 병원체나 비정상 세포를 신속하게 인식하고 제거하는 방어체계이며, 적응면역은 T세포 등이 특정 항원을 인식해 선택적으로 공격하고 면역기억을 형성하는 방식이다. 동사는 적응면역을 담당하는 T세포와 선천면역을 담당하는 대식세포를 각각 활성화하는 항체를 확보하고 있으며, 이를 기반으로 단일항체 및 이중항체 면역항암제를 개발하고 있다.

동사의 핵심 연구개발 전략은 단일항체를 기반으로 후속 파이프라인을 확장하는 프랜차이즈 항체(Franchise Antibody) 전략이다. T세포 중심의 적응면역을 활성화하는 ImmuneOn-T와 대식세포 중심의 선천면역을 활성화하는

ImmuneOn-M을 개발 플랫폼으로 구축하고 있으며, 대표적인 기반 항체는 PD-L1을 표적으로 하는 IMC-001과 CD47을 표적으로 하는 IMC-002다. 동사는 두 항체의 결합 특성 및 기존 연구개발 데이터를 활용해 PD-L1과 CD47을 동시에 표적으로 하는 이중항체 IMC-201을 개발하고 있으며, LAG-3 표적 항체와 다양한 이중항체 등으로 후속 파이프라인을 확대하고 있다. 이는 기존 항체를 활용해 신규 후보물질의 발굴 및 개발 효율성을 높이는 전략으로, 개별 파이프라인의 개발 성과를 후속 연구개발에 활용할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

프랜차이즈 항체 전략: 임상적 가치가 입증된 단클론항체 IMC-001과 IMC-002를 기반으로, 다양한 이중항체들로 확장 전략



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

T세포 활성화와 암세포 직접 제거 기능을 갖춘 PD-L1 항체

(1) IMC-001: PD-L1 표적 면역항암제

IMC-001(댄버스토투그, Danburstotug)은 PD-L1을 표적으로 하는 완전 인간 단클론항체로, 동사의 핵심 파이프라인 중 임상개발이 가장 앞서 있다. PD-L1은 암세포 등에 발현되는 단백질로, T세포 표면의 PD-1 수용체와 결합하면 T세포의 면역반응을 억제하는 신호를 전달한다. 암세포는 이러한 기전을 이용해 면역세포의 공격을 회피하는데, IMC-001은 PD-1과 PD-L1의 결합을 차단함으로써 T세포의 항암 기능을 회복시키는 역할을 한다.

IMC-001은 면역관문 억제 기능과 함께 항체의존세포독성(ADCC, Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)을 유도할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. ADCC는 항체가 암세포 표면의 단백질에 결합하면 NK세포 등 면역세포가 항체를 인식해 해당 암세포를 제거하는 작용이다. IMC-001은 IgG1 유형의 항체로, 항체의 Fc 영역을 통해 NK세포의 암세포 제거 기능을 유도할 수 있다. 즉, PD-L1 차단을 통한 T세포 활성화와 ADCC를 통한 암세포 제거 기능을 함께 활용하는 구조다. 이러한 작용기전은 면역관문 억제와 항체 매개 세포독성을 병행할 수 있다는 점에서 기술적 특징을 갖는다.

동사는 IMC-001의 우선 개발 적응증으로 희귀암인 NK/T세포림프종(NKTCL)을 선정하였다. NK/T세포림프종은 NK세

포 또는 T세포에서 발생하는 비호지킨림프종의 일종으로, 재발하거나 기존 치료에 반응하지 않는 환자에게 적용할 수 있는 치료법이 제한적이다. 이미 다양한 암종에서 PD-(L)1 계열 면역항암제가 상용화된 상황에서 동사는 상대적으로 미충족 의료 수요가 높고 경쟁 치료제가 제한적인 희귀암을 우선 공략하는 개발 전략을 채택하였다.

IMC-001은 재발성·불응성 NK/T세포림프종을 대상으로 임상 2상을 완료하였다. 해당 임상에서 객관적반응률(ORR)은 79%, 완전반응률(CR)은 63%를 기록하였으며, 2년 전체생존율(OS)은 78%로 보고되었다. 객관적반응률은 치료 후 종양 크기가 일정 기준 이상 감소한 환자의 비율이며, 완전반응률은 검사상 확인 가능한 종양이 소실된 환자의 비율을 의미한다. 특히 높은 완전반응률과 장기 생존 데이터는 기존 치료에 반응하지 않거나 재발한 환자에서 IMC-001의 임상적 유용성을 뒷받침하는 결과로 평가된다. 다만 대조군이 없는 단일군 임상시험인 만큼 기존 치료제 대비 우월성을 확정하기 위해서는 환자 특성과 임상설계 등의 차이를 고려할 필요가 있다.

동사는 2024년 유럽혈액학회(EHA)에서 임상 2상 결과를 발표한 데 이어 2025년 7월 임상결과보고서(CSR)를 완료하였으며, 2026년 8월에는 관련 임상 결과가 국제학술지 British Journal of Haematology에 게재되었다. 또한 2026년 1월 식품의약품안전처로부터 재발성·불응성 림프절외 NK/T세포림프종에 대한 희귀의약품 지정을 획득하였다. 현재 임상 2상 결과를 기반으로 국내 품목허가를 추진하고 있으며, 2029년 품목허가 신청과 2030년 국내 출시를 목표로 제조공정 개발 및 품질관리 체계 구축을 진행하고 있다.

(2) IMC-001 적응증 확대: TMB-High 고형암 및 수술 전 선행요법

TMB-High 고형암을 통한 시장 확장

IMC-001은 NK/T세포림프종 외에도 종양변이부담(TMB, Tumor Mutational Burden)이 높은 고형암으로 개발 범위를 확대하고 있다. TMB는 암세포 유전체에 축적된 유전자 변이의 정도를 의미하며, 일반적으로 유전자 변이가 많을수록 면역체계가 암세포를 구별할 수 있는 비정상 항원인 신생항원(Neoantigen)이 많이 생성될 가능성이 있다. 이에 따라 TMB는 면역관문억제제의 치료 반응을 예측하는 바이오마커 중 하나로 활용된다. 다만 TMB 수치가 높다고 모든 환자에서 면역항암제에 대한 치료 반응이 나타나는 것은 아니다.

TMB-High 고형암은 암이 발생한 장기보다 종양의 분자생물학적 특성을 기준으로 치료 대상 환자를 선별한다는 특징이 있다. 이러한 접근은 암종과 관계없이 특정 바이오마커를 보유한 환자에게 동일한 약물을 적용하는 암종불문치료(Tumor-Agnostic Therapy)에 해당한다. 대표적으로 MSD의 키트루다(Keytruda)는 2020년 미국 FDA로부터 TMB-High 고형암에 대한 허가를 획득하였으며, 해당 적응증에 대한 허가 기준으로 10 mut/Mb 이상의 종양변이부담을 적용하였다.

동사는 2024년 7월 TMB-High 고형암 대상 임상 2상의 환자 등록을 개시하였으며, 현재 임상시험을 진행 중이다. 해당 임상에서는 종양 유전체 100만 염기당 16개 이상의 변이(≥16 mut/Mb)를 환자 선별 기준으로 적용하고 있다. 이는 키트루다의 관련 허가 기준인 10 mut/Mb보다 높은 수준으로, 면역항암제에 대한 반응 가능성이 높은 환자군을 선별하기 위한 전략이다. 다만 환자 선별 기준과 검사방법의 차이가 존재하므로 높은 TMB 기준이 실제 치료 효능의 개선으로 이어지는지는 임상 결과를 통해 확인할 필요가 있다. 동사는 2027년 상반기 환자 등록 완료를 목표로 하고 있으며, 향후 확보되는 임상 데이터를 기반으로 해외 기술이전 및 추가 적응증 개발을 추진할 계획이다.

한편 IMC-001은 수술 전 선행요법(Neoadjuvant Therapy)으로의 활용 가능성도 검토되고 있다. 수술 전 선행요법은 종양의 크기를 줄이거나 수술 이후 재발 위험을 낮추기 위해 수술 전에 항암치료를 시행하는 방식이다. 동사는 위암·식도암·간세포암 등 절제 가능한 암종을 대상으로 IMC-001의 수술 전 투여 효과를 평가한 NeoChance 임상 2상 연구를 완료하였으며, 2025년 유럽종양학회(ESMO)에서 관련 결과를 발표한 데 이어 2026년 7월 연구 결과가 학술지에 게재되었다. 해당 연구는 IMC-001의 적용 범위를 진행성 암환자 중심의 치료에서 수술 전 치료 영역으로 확대할 가능성을 검토했다는 점에서 의미가 있다. 다만 현재는 임상적 활용 가능성을 평가한 단계로, 향후 실제 적응증 확보를 위해서는 추가적인 개발 및 허가 절차가 필요하다.

(3) IMC-002: CD47 표적 면역항암제

정상 혈액세포 결합을 최소화한 차세대 CD47 항체

IMC-002는 CD47을 표적으로 하는 완전 인간 단클론항체로, 글로벌 기술이전을 목표로 개발 중인 핵심 파이프라인이다. CD47은 암세포를 포함한 다양한 세포의 표면에 존재하는 단백질로, 대식세포 표면의 SIRPα 수용체와 결합해 해당 세포를 제거하지 않도록 하는 신호를 전달한다. 이른바 'Don't Eat Me' 신호로 불리는 이러한 기전은 정상세포가 불필요하게 제거되는 것을 방지하는 역할을 하지만, 암세포 역시 CD47을 활용해 대식세포의 공격을 회피할 수 있다.

CD47 표적 항체는 CD47과 SIRPα의 결합을 차단해 대식세포가 암세포를 포식(Phagocytosis)하도록 유도한다. 또한 대식세포 등에 의해 처리된 암세포의 항원이 수지상세포(Dendritic Cell)를 통해 T세포에 제시되면 적응면역 반응도 활성화될 수 있다. 따라서 CD47 표적 치료제는 대식세포 중심의 선천면역을 직접 활성화하는 동시에 적응면역 반응까지 유도할 가능성이 있는 면역항암제다.

다만 CD47은 암세포뿐 아니라 적혈구와 혈소판 등 정상 혈액세포에도 발현된다는 점이 신약개발의 주요 장애요인이다. 기존 CD47 항체는 정상 혈액세포에도 결합해 빈혈 등 혈액독성을 유발할 수 있으며, 정상세포에 대한 약물 결합으로 암세포에 도달하는 유효 약물량이 감소하는 문제도 발생할 수 있다. 실제 글로벌 제약사들이 개발한 일부 CD47 표적 항체는 안전성 또는 유효성 문제로 임상개발이 중단된 바 있다. 이에 따라 정상세포에 대한 결합을 최소화하면서 암세포에 대한 항종양 효과를 유지하는 것이 차세대 CD47 항체의 핵심 개발 과제로 평가된다.

IMC-002는 기존 CD47 항체와 차별화된 항원결합부위(Epitope)를 인식하도록 설계된 IgG4 유형의 항체다. 항원결합부위는 항체가 표적 단백질에 결합하는 특정 영역을 의미하며, 동일한 CD47을 표적으로 하더라도 결합 위치와 방식에 따라 정상세포 및 암세포에 대한 결합 특성이 달라질 수 있다. 동사의 비임상 연구에서는 IMC-002가 암세포에 결합하는 반면 적혈구, 혈소판 및 백혈구 등 정상 혈액세포에 대한 결합은 낮은 것으로 나타났다. 이러한 특성은 CD47 항체에서 문제가 됐던 적혈구 응집 및 혈액독성 위험을 줄일 수 있는 기술적 근거로 평가된다.

2026년 미국암연구학회(AACR)에서는 극저온 전자현미경(Cryo-EM)을 활용한 IMC-002의 결합구조 분석 결과가 발표되었다. 해당 연구에서는 IMC-002가 기존 CD47 항체와 달리 당화 변형(O-glycosylation)이 일어나는 부위 주변에 결합하며, 항체의 결합 위치와 각도에도 차이가 있는 것으로 확인되었다. 이러한 구조적 특성은 적혈구 사이의 교차결합 및 응집 가능성을 낮출 수 있는 요인으로 분석된다. 기존 비임상시험에서 관찰된 낮은 적혈구 결합 특성을 분자구조 차원에서 설명할 수 있는 근거가 확보됐다는 점에서 의미가 있다. 다만 이러한 기술적 특성이 실제 임상에서 혈액독

성 위험을 어느 정도 낮추는지는 추가적인 안전성 데이터가 필요하다.

IMC-002는 임상 1a상에서 최대 30mg/kg 투여 용량까지 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않았으며, 후속 임상을 위한 권장용량(RP2D)으로 20mg/kg을 3주 간격으로 투여하는 요법을 선정하였다. 동사는 이를 기반으로 간세포암(HCC), 삼중음성유방암(TNBC), 담도암(BTC) 등 치료 선택지가 제한적인 고형암을 대상으로 임상 1b상을 진행하고 있다. 또한 2026년 8월에는 췌장암(PDAC) 코호트 추가에 대한 임상시험계획 변경 승인을 획득하면서 개발 대상 암종을 확대하였다. 임상 1b상은 IMC-002를 렌바티닙 또는 항암화학요법 등 기존 치료제와 병용 투여해 안전성과 유효성을 평가하는 방식으로 진행되고 있다.

임상 유효성 측면에서는 간세포암과 삼중음성유방암에서 초기 항종양 활성 신호가 확인되고 있다. 2025년 미국임상종양학회(ASCO)에서 발표한 간세포암 대상 IMC-002와 렌바티닙 병용요법의 객관적반응률(ORR)은 30%를 기록하였다. 또한 탐색적 바이오마커 분석에서는 CD47의 암세포막 발현 수준이 높은 환자군에서 ORR 60%, 질병통제율(DCR) 80%가 관찰되었다. 질병통제율은 종양이 감소하거나 일정 기간 추가 진행 없이 유지된 환자의 비율을 의미한다. 이어 2026년 ASCO에서 공개된 삼중음성유방암 임상 1b상에서는 젬시타빈·카보플라틴 또는 파클리탁셀 병용요법으로 ORR 25%, DCR 75%, 임상적 이득률(CBR) 42%를 기록하였다. 해당 임상에서는 3차 이상 전신치료 경험이 있는 환자가 전체의 92%를 차지해 치료이력이 많은 환자군에서 유효성 신호가 관찰됐다는 점에 의미가 있다.

안전성 측면에서는 IMC-002의 구조적 차별화 가능성과 함께 일부 혈액학적 이상반응도 확인되었다. 동사가 공개한 삼중음성유방암 임상 결과에서는 3등급(Grade 3) 빈혈 및 용혈성 빈혈이 보고되었으나, 혈소판 및 백혈구 감소증은 관찰되지 않았다. 이는 IMC-002의 혈액독성 위험이 완전히 해소된 것은 아니며, 추가적인 환자 데이터를 통해 안전성 특성을 검증할 필요가 있음을 의미한다. 또한 간세포암과 삼중음성유방암에서 확인된 반응률은 모두 소규모 병용요법 임상 결과이므로, IMC-002의 독립적인 치료 효과나 기존 치료제 대비 우월성을 판단하기에는 한계가 있다. 향후 복수 암종에서 유효성 및 안전성 결과의 재현 여부가 중요한 평가요인이 될 전망이다.

동사는 2021년 중국 3D메디슨(3D Medicines)에 IMC-002의 중국 지역 개발·상업화 권리를 기술이전한 바 있으며, 현재는 미국과 유럽을 포함한 글로벌 시장을 대상으로 추가 기술이전을 추진하고 있다. 이를 위해 복수의 고형암에서 임상적 개념증명(PoC, Proof of Concept)을 확보하는 데 주력하고 있으며, 2027년 추가 임상 결과 발표를 추진하고 있다. 향후 기술이전 가능성을 높이기 위해서는 종양반응률뿐 아니라 반응지속기간, 무진행생존기간 및 혈액학적 안전성 등에 대한 충분한 임상 데이터를 확보하는 것이 중요할 전망이다.

(4) IMC-201 및 후속 파이프라인

단일항체 기반 이중항체로 개발영역 확장

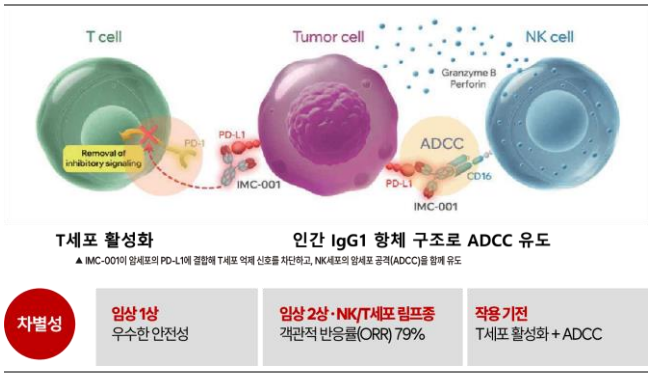
IMC-201은 IMC-001의 PD-L1 항체와 IMC-002의 CD47 항체를 기반으로 개발한 이중항체(Bispecific Antibody) 파이프라인이다. 일반적인 단일항체가 하나의 표적을 인식하는 반면, 이중항체는 서로 다른 두 표적에 동시에 결합하도록 설계된다. IMC-201은 암세포 표면의 PD-L1과 CD47을 동시에 표적으로 하며, PD-L1과 PD-1의 결합을 차단해 T세포를 활성화하는 동시에 CD47과 SIRPα의 상호작용을 억제해 대식세포의 암세포 포식작용을 유도한다. 여기에 IgG1 항체의 Fc 영역을 통한 ADCC 기능도 활용할 수 있도록 설계되었다.

IMC-201의 개발 목적은 적응면역과 선천면역을 하나의 약물로 동시에 활성화해 기존 단일항체의 치료 효과를 개선하는 데 있다. 특히 CD47과 PD-L1이 함께 발현된 암세포에 대한 결합력을 높여 정상세포에 대한 영향을 줄이는 종양 선택성 향상 전략을 적용하고 있다. 동사는 비임상 동물시험에서 IMC-201의 종양 증식 억제 효과를 확인하였으며, 일부 시험에서는 기반 단일항체의 병용투여 대비 강화된 항종양 효과를 제시하였다. 또한 치료 후 종양이 소실된 동물에 암세포를 다시 이식한 시험에서 종양 재성장이 억제되는 결과를 확인해 면역기억 형성 가능성을 제시하였다. 다만 이러한 결과는 비임상 단계에서 확인된 것으로, 실제 환자에서의 안전성과 치료 효능은 아직 검증되지 않았다.

동사는 삼중음성유방암을 비롯한 고형암을 중심으로 IMC-201의 개발을 추진하고 있으며, 세포주 및 생산공정 개발과 비임상 독성시험 등을 진행하고 있다. 2026년 9월에는 국내에 이어 일본에서 관련 특허를 등록했으며, 현재 임상시험계획(IND) 제출을 위한 준비를 진행 중이다. 회사는 2027년 IND 제출을 목표로 하고 있으며, 비임상 자료 확보 및 임상개발 진전에 따라 글로벌 기술이전을 추진할 계획이다.

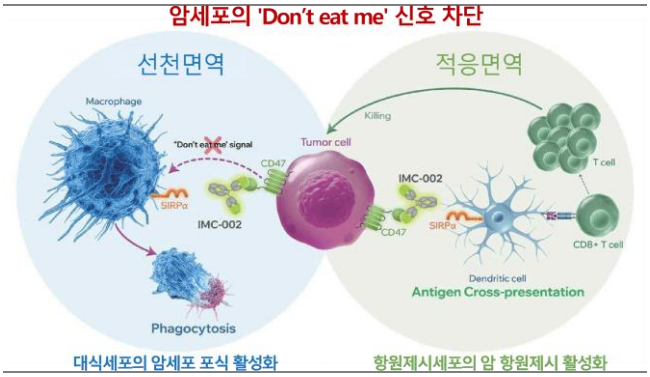
이외에도 동사는 LAG-3 표적 단일항체 IMC-003, PD-L1·TIGIT 표적 이중항체 IMC-202 및 CD47 기반 후속 후보물질 등에 대한 연구개발을 진행하고 있다. 이러한 파이프라인은 기존 항체의 결합 특성과 개발 경험을 활용해 신규 표적 및 복합 작용기전으로 연구개발 영역을 확장하는 전략의 일환이다. 다만 주요 임상 파이프라인에 비해 개발 초기 단계에 있어, 향후 비임상 효능과 안전성 검증을 통한 후보물질의 경쟁력 확보 여부가 중요할 전망이다.

IMC-001 기전 및 차별성



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

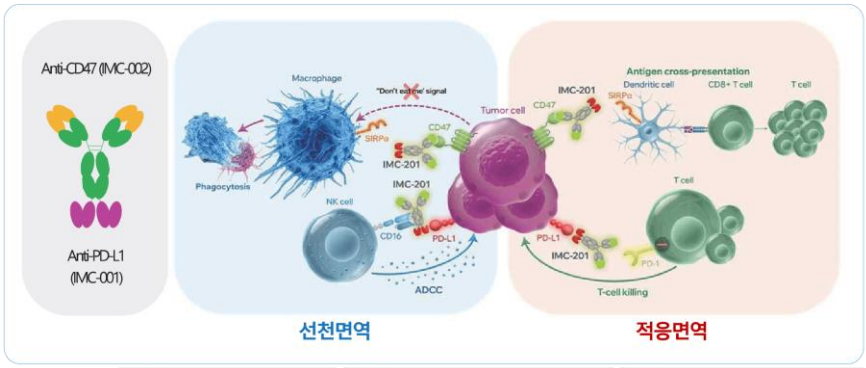
IMC-002 기전



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

IMC-201: CD47과 PD-L1을 동시 타겟(선천면역과 적응면역을 동시 활성화)

IMC-201 기전 및 차별성

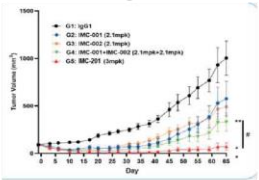


차별성

1. **우수한 안전성**
   모항체의 암세포 선택성
2. **우수한 효능**
   모항체 병용 대비 시너지 효과
   면역 기억 능력 확인
3. **우수한 약동학(PK)**
   이중항체 구조에도 불구하고
   반감기 86일(마우스)

주요 비임상 결과

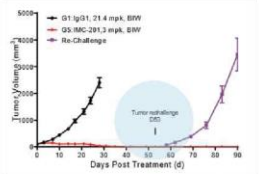
MDA-MB-231 Xenograft Mouse Model



암성장 억제 효과
모항체 병용 대비 우수
시너지 효과 확인

▲ 시간에 따른 종양 부피(낮을수록 억제 효과 큼)

Test article in Female BALB/c-hPD1/hSIRPα Mice Bearing CT26 -hPDL1/hCD47 Tumor Syngeneic Model Tumor Volume mean ± SEM



면역 기억 능력
완전관해(CR) 개체에
동일 종양세포 재주입 시에도
종양 재성장 억제
장기치료효과, 재발 예방

▲ 완치 개체에 암세포 재이식 후 재발 억제 확인

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

산업 현황

1 면역관문억제제 중심으로 발전하는 항암제 시장

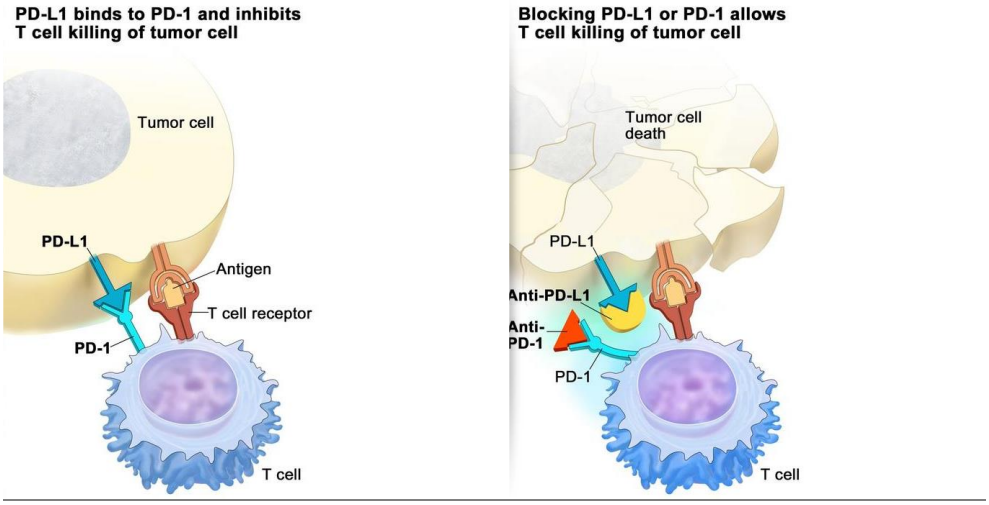
PD-(L)1 억제제를 중심으로 면역항암제의 적용 범위가 다양한 암종과 병용요법, 수술 전후 치료로 확대되며 항암치료의 주요 축으로 자리매김

항암제 시장은 세포독성항암제에서 표적항암제, 면역항암제로 치료 방식이 다변화되면서 발전해 왔다. 세포독성항암제는 빠르게 증식하는 세포를 공격하는 방식으로 암세포뿐 아니라 정상세포에도 영향을 미칠 수 있으며, 표적항암제는 암세포의 증식과 생존에 관여하는 특정 유전자나 단백질을 선택적으로 억제한다. 반면 면역항암제는 인체의 면역체계를 활용해 암세포를 제거하는 방식으로, 면역세포의 항암 기능을 회복하거나 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 특히 면역항암제는 일부 환자에서 치료 종료 이후에도 면역반응이 지속되면서 장기적인 치료 효과를 나타낼 수 있다는 점에서 기존 항암제와 차별화된다.

면역항암제 중 상업화가 가장 활발하게 진행된 분야는 면역관문억제제(Immune Checkpoint Inhibitor)다. 면역관문은 면역세포가 정상세포를 과도하게 공격하지 않도록 면역반응을 조절하는 기능을 하지만, 암세포는 이러한 기전을 활용해 면역체계의 공격을 회피할 수 있다. 대표적으로 PD-1과 PD-L1, CTLA-4 등이 주요 면역관문 단백질로 알려져 있으며, 이를 표적으로 하는 항체의약품은 면역억제 신호를 차단해 T세포의 항암 기능을 활성화한다. 특히 PD-1 또는 PD-L1을 표적으로 하는 면역관문억제제는 암세포가 T세포의 공격을 회피하는 주요 경로를 차단한다는 점에서 면역항암제 시장의 핵심 치료제로 자리 잡았다.

2014년 미국 FDA가 MSD의 키트루다(Keytruda)와 BMS의 옵디보(Opdivo)를 승인한 이후 PD-(L)1 계열 면역항암제는 흑색종과 폐암을 비롯한 다양한 암종으로 적응증을 확대해 왔다. 초기에는 기존 치료에 반응하지 않는 진행성 암환자를 대상으로 단독요법 개발이 이루어졌으나, 이후 항암화학요법 및 다른 면역항암제와의 병용요법, 수술 전 선행요법과 수술 후 보조요법 등으로 적용 범위가 확대되었다. 특히 면역항암제와 기존 치료법을 병용해 치료 반응을 높이거나, 상대적으로 초기 단계의 암환자에게 적용해 재발 위험을 낮추려는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 이에 따라 면역관문억제제는 일부 암종에서 표준치료의 한 축으로 자리 잡았으며, 적용 적응증과 치료 단계의 확대를 통해 항암제 시장 내 중요성이 높아지고 있다.

면역관문억제제의 작용기전



자료: NIH(National Cancer Institute), 한국IR협의회 기업리서치센터

2 PD-(L)1 시장의 성장과 미충족 의료 수요

2025년 키트루다 매출 약 317억달러 기록. 시장 성숙에 따라 희귀암, 바이오마커 기반 환자 선별 및 병용요법을 통한 차별화 중요성 확대

글로벌 PD-(L)1 면역항암제 시장은 주요 블록버스터 의약품을 중심으로 대규모 매출 기반을 형성하고 있다. MSD(미국)의 키트루다(Keytruda) 및 키트루다 큐렉스(Keytruda Qlex)의 2025년 합산 매출액은 약 317억달러(+7% YoY)를 기록하였으며, BMS(미국)의 옵디보(Opdivo)는 약 100억달러(+8% YoY), 아스트라제네카(영국)의 임핀지(Imfinzi)는 약 61억달러(+29% YoY)의 매출을 기록하였다. 특히 임핀지는 폐암과 방광암 등에서 신규 적응증 확대에 힘입어 높은 성장률을 나타냈다. 이는 PD-(L)1 계열 의약품이 이미 상당한 시장 규모를 확보했음에도 치료 대상 환자군과 적용 단계의 확대를 통해 추가 성장하고 있음을 보여준다.

PD-(L)1 계열 면역항암제의 성장에는 적응증 확대와 병용요법 개발이 주요 요인으로 작용하고 있다. 초기에는 기존 치료에 실패한 진행성 암환자를 대상으로 개발이 이루어졌으나, 이후 1차 치료와 수술 전후 보조요법 등으로 적용 범위가 확대되었다. 또한 항암화학요법, 표적항암제 및 다른 면역관문억제제와의 병용을 통해 치료 효과를 높이려는 연구가 지속되고 있다. 다만 PD-(L)1 계열은 이미 다수의 상용화 의약품이 존재하는 성숙시장으로, 후발 신약이 동일한 작용기전만으로 경쟁력을 확보하기는 어려운 상황이다. 이에 따라 기존 치료제와 차별화된 항암 효능과 안전성, 새로운 적응증 확보 여부가 신약의 경쟁력을 결정하는 주요 요인으로 부각되고 있다.

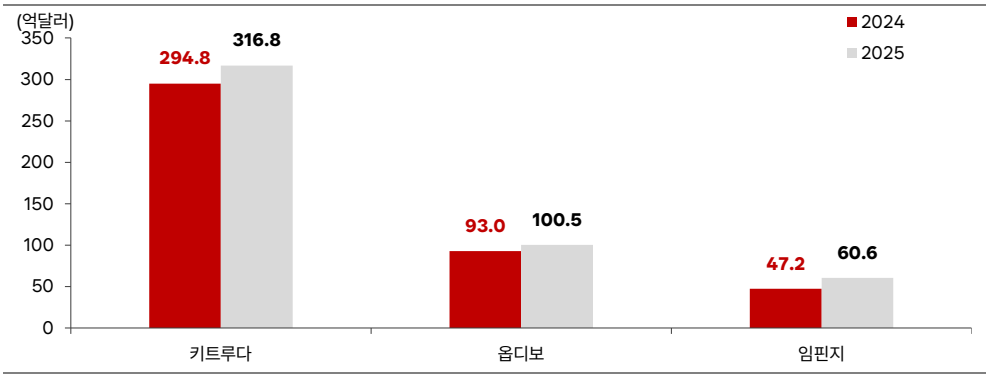
시장 성장에도 불구하고 면역관문억제제의 치료 효과에는 한계가 존재한다. PD-(L)1 억제제는 암세포에 대한 면역반응이 이미 형성된 환자에서 효과적으로 작용할 수 있지만, 종양 내 T세포가 부족하거나 면역억제 환경이 강하게 형성된 환자에서는 치료 효과가 제한될 수 있다. 또한 초기 치료에 반응하더라도 약제 내성이 발생하거나 암이 재발하는 사례가 존재한다. 따라서 기존 면역관문억제제에 반응하지 않는 환자를 위한 새로운 작용기전의 신약과 치료 효과를 개선할 수 있는 병용요법 개발이 지속되고 있다. 특히 T세포 외에 대식세포 등 다른 면역세포를 활성화하는 치료제와 이중항체 등이 기존 면역항암제의 한계를 보완하기 위한 개발 방향으로 주목받고 있다.

이와 함께 환자의 종양 특성을 분석해 치료 반응 가능성이 높은 환자를 선별하는 정밀의료 접근의 중요성도 높아지고

있다. 대표적인 바이오마커로는 PD-L1 발현 수준, 종양변이부담(TMB), 현미부수체 불안정성(MSI) 등이 있으며, 이러한 지표를 활용하면 특정 치료제에 반응할 가능성이 높은 환자군을 선별할 수 있다. 키트루다는 2020년 미국 FDA로부터 TMB-High 고형암에 대한 가속승인을 획득하였으며, 당시 KEYNOTE-158 임상시험에서 TMB가 10 mut/Mb 이상인 환자 102명의 객관적반응률(ORR)은 29%로 나타났다. 이는 바이오마커 기반 환자 선별이 치료 효과를 높이는 데 활용될 수 있음을 보여주는 동시에, 선별된 환자군에서도 상당수가 치료에 반응하지 않아 추가적인 치료제 개발 수요가 존재한다는 점을 시사한다.

희귀암 역시 미충족 의료 수요가 높은 분야로 평가된다. 희귀암은 환자 수가 적어 대규모 임상시험 수행이 어렵고 상업적 시장 규모도 제한적이기 때문에 일부 암종에서는 효과적인 치료제가 충분히 개발되지 못한 상황이다. 특히 재발성·불응성 NK/T세포림프종과 같이 기존 치료 이후 선택 가능한 치료법이 제한적인 암종에서는 새로운 면역항암제에 대한 개발 수요가 존재한다. 이에 따라 후발 면역항암제 개발기업은 이미 경쟁이 치열한 대규모 적응증보다는 미충족 의료 수요가 높은 희귀암에서 우선 임상적 가치를 확보한 뒤, 바이오마커 기반 고형암 등으로 적응증을 확대하는 전략을 추진하고 있다. 향후 PD-(L)1 시장에서는 기존 치료제 대비 차별화된 임상적 유효성과 환자 선별 전략을 확보한 후보물질을 중심으로 경쟁이 전개될 전망이다.

글로벌 주요 PD-(L)1 면역항암제 매출 추이



주: 키트루다의 2025년 매출은 키트루다 큐렉스 포함. 각 제약사 공시 기준으로 집계하였으며 PD-(L)1 전체 시장 규모를 의미하지 않음
자료: 각 사(Merck, BMS, AstraZeneca), 한국IR협의회 기업리서치센터

3 CD47 표적 치료제 개발 경쟁과 차세대 이중항체

선행 CD47 항체들의 개발 중단 이후 혈액독성 개선과 항종양 효능 확보가 핵심 경쟁요인으로 부각. 후속 약물의 임상 3상 진전 및 이중항체 개발 확대

기존 PD-(L)1 면역관문억제제가 주로 T세포를 통한 적응면역 활성화에 초점을 맞춘다면, CD47 표적 치료제는 대식세포를 통한 선천면역 활성화를 유도한다는 차이가 있다. CD47은 암세포를 포함한 다양한 세포의 표면에 존재하는 단백질로, 대식세포의 SIRPα 수용체와 결합해 해당 세포를 제거하지 않도록 하는 신호를 전달한다. 암세포 역시 CD47을 과발현해 대식세포의 공격을 회피할 수 있는데, CD47과 SIRPα의 상호작용을 차단하면 대식세포의 암세포 포식작용을 촉진할 수 있다. 특히 이러한 작용은 T세포 중심의 기존 면역항암제와 다른 면역반응을 활용한다는 점에서 새로운 치료 기전으로 주목받고 있다.

다만 CD47은 암세포뿐 아니라 적혈구와 혈소판 등 정상 혈액세포에도 발현된다는 점이 신약개발의 주요 장애요인이다. CD47 항체가 정상 혈액세포에 결합하면 빈혈 등 혈액독성이 발생할 수 있으며, 정상세포에 약물이 결합하면서 암세포에 도달하는 유효 약물량이 감소하는 현상(Antigen Sink)도 나타날 수 있다. 따라서 CD47 표적 치료제는 암세포에 대한 항종양 효과를 유지하면서 정상 혈액세포와의 결합을 최소화하는 것이 중요하다. 이에 따라 최근에는 항체의 결합 위치와 구조를 조절하거나, CD47 외에 암세포에 특이적으로 발현되는 다른 표적을 함께 인식하도록 설계하는 방식으로 개발 전략이 다변화되고 있다.

CD47 표적 치료제는 한때 글로벌 제약사들의 대규모 인수합병을 통해 주목받았으나, 임상개발 과정에서 안전성 및 유효성 문제가 부각되면서 개발 전략이 변화하고 있다. 대표적으로 길리어드사이언스(Gilead Sciences)는 2020년 CD47 항체 매그롤리맙(Magrolimab)을 보유한 포티세븐(Forty Seven)을 약 49억달러에 인수하였다. 그러나 이후 급성골수성백혈병(AML)과 골수이형성증후군(MDS) 대상 임상시험에서 유효성 부족과 사망 위험 증가 등의 문제가 확인되면서 2024년 혈액암 분야의 개발을 중단하였다. 고형암 대상 임상시험에서도 환자 등록이 중단되는 등 개발에 차질을 빚었다. 이러한 사례는 CD47 표적 차단이라는 작용기전만으로 임상적 성공을 보장할 수 없으며, 안전성과 유효성의 동시 확보가 중요하다는 점을 보여준다.

선발 약물의 개발 중단에도 불구하고 후속 CD47 표적 치료제의 임상개발은 지속되고 있다. 중국 아케소바이오(Akeso)의 리구팔리맙(Ligufalimab, AK117)은 정상 적혈구와의 결합을 줄이도록 설계된 CD47 항체로, 혈액암과 고형암에서 임상개발을 진행하고 있다. 특히 PD-1·VEGF 이중항체인 이보네시맙(Ivonescimab)과의 병용요법을 중심으로 두경부편평세포암 및 췌장암 대상 임상 3상을 진행 중이며, 급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 대상 임상 2상도 진행하고 있다. 이는 CD47 표적 치료제의 개발이 단독요법보다는 다른 면역항암제 및 기존 치료제와의 병용을 통해 임상적 유효성을 확보하는 방향으로 확대되고 있음을 보여준다.

미국 ALX Oncology의 에보파셉트(Evorpacept)는 CD47에 결합하는 SIRPα 기반 융합단백질로, 기존 CD47 항체와 다른 구조를 활용해 정상 혈액세포에 대한 영향을 줄이는 전략을 채택하고 있다. 2026년 9월 국제학술지 Nature Medicine에 발표된 HER2 양성 위암 대상 ASPEN-06 임상 2상에서는 에보파셉트와 트라스투주맙·라무시루맙·파클리탁셀 병용군의 객관적반응률(ORR)이 40.3%로, 대조군의 26.6%를 상회하였다. 특히 종양의 HER2 양성 상태가 유지되고 CD47 발현 수준이 높은 환자군에서 치료 반응이 높게 나타나 바이오마커 기반 환자 선별의 가능성도 제시되었다. 다만 임상 2상에서 확인된 결과인 만큼 후속 임상에서 치료 효과와 안전성을 추가로 검증할 필요가 있다.

최근에는 서로 다른 면역관문을 하나의 약물로 동시에 표적하는 이중항체(Bispecific Antibody)도 차세대 면역항암제 개발 방향으로 부상하고 있다. 이중항체는 두 가지 표적을 동시에 인식하도록 설계된 항체로, 서로 다른 면역반응을 함께 활성화하거나 암세포에 대한 선택성을 높이는 데 활용된다. 특히 PD-(L)1과 CD47을 동시에 표적하는 이중항체는 T세포의 면역억제 신호를 차단하는 동시에 대식세포의 암세포 포식작용을 활성화하는 구조다. 또한 암세포에서 함께 발현되는 두 표적에 대한 결합 특성을 활용하면 정상세포에 대한 비특이적 결합을 줄일 가능성도 있다. 다만 복수의 표적을 동시에 억제하는 만큼 약물의 구조와 생산공정이 복잡해지고, 예상하지 못한 면역 관련 이상반응이 발생할 가능성도 고려해야 한다.

CD47 표적 치료제는 선발 약물들의 임상개발 중단 이후 정상 혈액세포에 대한 결합을 줄이는 기술적 차별화와 적응증별 유효성 확보를 중심으로 개발 경쟁이 재편되고 있다. 일부 후속 약물에서 임상 성과가 축적되고 있지만, 상용화를 위해서는 충분한 규모의 임상시험을 통해 치료 효과와 안전성을 입증해야 한다. 특히 기존 면역항암제와의 병용요법, 바이오마커 기반 환자 선별, 이중항체를 통한 종양 선택성 개선 등이 주요 개발 방향으로 평가된다. 향후 CD47 계열에서는 정상세포에 대한 영향을 최소화하면서 일관된 항종양 효과를 확인한 후보물질을 중심으로 경쟁력이 차별화될 전망이다.

CD47 표적 신약 주요 개발사 비교

개발사	파이프라인	약물유형	개발 현황
길리어드사이언스 (미국)	Magrolimab	CD47 단클론항체	2024년 AML·MDS 등 혈액암 개발 중단. 고형암 임상 환자 등록 중단 및 일부 임상 조기 종료
Akeso (중국)	Ligufalimab (AK117)	CD47 단클론항체	두경부편평세포암·췌장암 임상 3상 진행 중(병용요법). AML·MDS 등 혈액암 임상 2상
ALX Oncology (미국)	Evorpacept	CD47 결합 SIRPα-Fc 융합단백질	HER2 양성 위암 임상 2상 결과 발표(2026.09), 미국 임상 3상 미추진. HER2 양성 유방암 임상 2상 진행 중
이뮨온시아	IMC-002	CD47 단클론항체	간세포암·삼중음성유방암·담도암 임상 1b상 진행 중. 2026년 췌장암 코호트 추가 승인

자료: 각 사 발표자료(Gilead Sciences, Akeso, ALX Oncology, 이뮨온시아), 한국IR협의회 기업리서치센터

투자포인트

1 IMC-001, 국내 상용화 및 적응증 확대를 통한 사업화 추진

IMC-001은 NK/T세포림프종 임상 2상 성과를 기반으로 국내 상용화를 추진 중. 또한 TMB-High 고형암 적응증 확대를 통해 해외 기술이전 및 추가 수익 창출 모색

이뮨온시아는 핵심 파이프라인인 IMC-001(댄버스토투그)의 국내 상용화와 해외 기술이전을 병행하는 이원화 전략을 추진하고 있다. 우선 치료 선택지가 제한적인 희귀 혈액암인 NK/T세포림프종을 대상으로 국내 품목허가를 확보한 뒤, 다양한 고형암으로 적응증을 확대한다는 계획이다. 동사는 재발성·불응성 NK/T세포림프종 대상 임상 2상을 완료하였으며, 객관적반응률(ORR) 79%, 완전반응률(CR) 63%, 2년 전체생존율(OS) 78%를 기록하였다. 이는 기존 치료에 반응하지 않거나 재발한 환자에서 유의미한 항종양 효과를 확인한 성과로 평가된다. 다만 단일군 임상시험 결과인 만큼 기존 치료제 대비 우월성은 추가 검증이 필요하다. 동사는 2025년 7월 임상결과보고서(CSR)를 완료하였으며, 2026년 8월에는 관련 임상 결과가 국제학술지 British Journal of Haematology에 게재되었다.

IMC-001의 국내 상용화 준비도 구체화되고 있다. 동사는 2026년 1월 식품의약품안전처로부터 재발성·불응성 NK/T세포림프종에 대한 희귀의약품 지정을 획득하였으며, 임상 2상 결과를 기반으로 품목허가를 추진하고 있다. 현재 2029년 품목허가 신청과 2030년 국내 출시를 목표로 하고 있으며, 상업생산을 위한 제조공정 개발과 품질관리 체계 구축을 진행 중이다. 희귀의약품 지정이 품목허가를 보장하는 것은 아니지만, 임상개발 성과를 바탕으로 허가 및 생산 준비가 본격화되고 있다는 점에서 상용화를 위한 기반이 강화되고 있다.

동사는 희귀암을 통한 초기 시장 진입과 함께 TMB-High 고형암으로 IMC-001의 개발 범위를 확대하고 있다. TMB-High 고형암은 암이 발생한 장기와 관계없이 종양의 유전자 변이가 많은 환자를 선별하는 암종불문치료 분야로, NK/T세포림프종보다 폭넓은 환자군을 대상으로 개발할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 현재 미국에서는 MSD의 키트루다(Keytruda)가 해당 적응증에 대한 허가를 확보하고 있으나, 기존 면역항암제에 반응하지 않는 환자군이 여전히 존재한다. 동사는 TMB-High 고형암 대상 임상 2상을 진행 중이며, 치료 반응 가능성이 높은 환자군을 선별하기 위해 16 mut/Mb 이상의 종양변이부담을 기준으로 적용하고 있다. 2027년 상반기 환자 등록 완료를 목표로 하고 있으며, 향후 임상에서 유의미한 치료 효과가 확인될 경우 IMC-001의 시장 확대 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

또한, TMB-High 고형암 임상개발 성과를 기반으로 2027년 유럽 기술이전을 추진하고 있다. 동사는 기존 계약금(Upfront), 개발 단계별 마일스톤(Milestone), 로열티(Royalty) 중심의 기술이전 방식에 의약품 공급을 결합한 사업모델을 제시하고 있다. 기술이전 이후에도 임상시험용 의약품을 공급하고, 향후 상업화 단계에서는 완제의약품 공급으로 확대해 추가 매출을 확보한다는 전략이다. 이는 기술이전 수익 외에 의약품 공급을 통한 매출을 창출할 수 있다는 점에서 수익원 다변화의 의미가 있다. 다만 해외 기술이전은 아직 추진 단계로, 실제 계약 체결과 수익 실현 여부는 향후 임상 결과 및 계약조건에 따라 결정될 전망이다. 중장기적으로 국내 품목허가 절차의 진전과 TMB-High 고형암 임상 성과, 유럽 기술이전 여부가 IMC-001의 사업화 가치를 결정하는 주요 요인으로 판단된다.

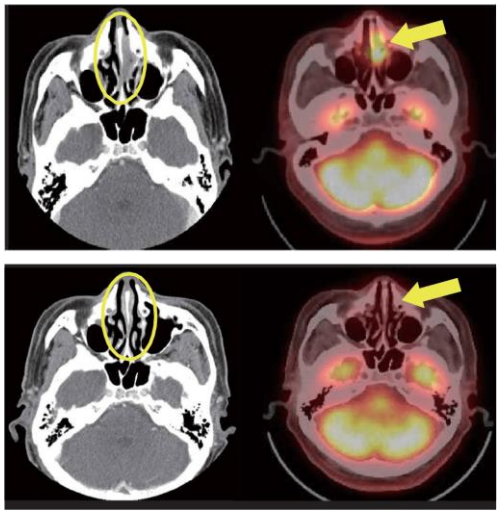
임상 2상: 1차 임상목표 초과 달성

객관적 반응률(ORR) 79%
완전관해율(CR) 63%

완전관해(CR) 환자의 PET-CT 영상

IMC-001
투약 전

IMC-001
투약 12주차



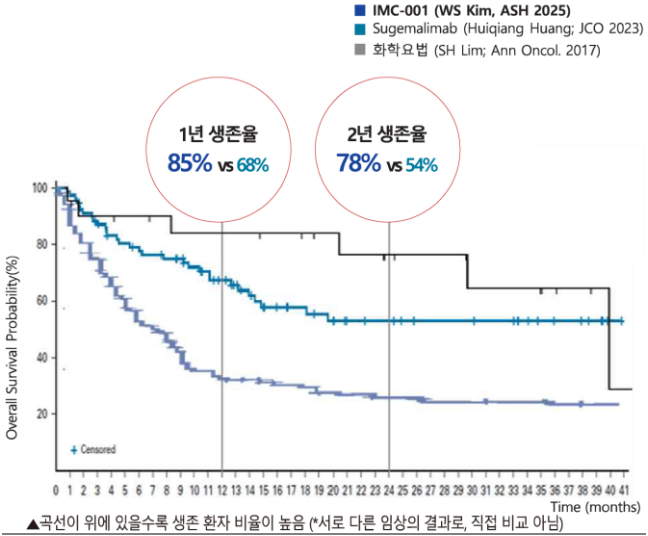
▲ PET-CT: 투약 전 종양 부위(화살표)의 대사 신호가 12주차에 소실(완전관해)

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

임상 2상: 기존 요법 대비 생존기간 개선 확인

2년 전체생존율(OS) 78%
화학요법 23%, Sugemalimab 54%

NK/T세포 림프종 전체생존율(OS) 비교*



▲곡선이 위에 있을수록 생존 환자 비율이 높음 (*서로 다른 임상의 결과로, 직접 비교 아님)

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

IMC-001 상용화 전략: 희귀암에서 보편암으로, 키트루다 공백을 겨냥한 TMB-High 고형암으로 적응증 확장 추진

Danburstotug (IMC-001) 전략

① 적응증 확장
희귀암 NK/T세포 림프종 → 보편암(범암종) TMB-H 고형암

② 시장 공백 · 키트루다 대체 기회
키트루다 · 미국 특허 2028년 만료, 유럽 TMB-H 적응증 미허가
IMC-001 · 특허 2037년 만료, 유럽 수요 선점 추진
*키트루다(펨브롤리주맙, MSD): 2025년 글로벌 매출 $31.7B(약 44조 원)로 세계 매출 1위 의약품

Danburstotug (IMC-001) 로드맵

STEP 1 2027 상반기 환자 등록 완료
국내 임상 환자 등록 완료
투약 6개월 후 유효성 데이터 확보

STEP 2 2027 유럽 기술이전 추진
L/O + 의약품 공급 동시 진행
Hybrid Licensing 모델

STEP 3 2027 기술이전 이후 매출 구조 실현
임상용 → 상업용 공급 전환
Cost + Mark-up 구조

기술이전 시 예상 사업구조

유럽 등 기술이전 추진	임상 의약품 공급	Upfront·마일스톤	로열티 수취
유럽 → 타 지역 확산 목표	공급매출 확보 가능	기술이전 계약 수익	상업 매출 연동 수익

L/O와 의약품 공급을 동시에 확보 → 기술료 + 공급매출의 이중 수익 구조로 유럽 시장 진입

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

IMC-002, 구조적 차별성과 임상 성과를 기반으로 글로벌 기술이전 추진

IMC-002는 정상 혈액세포에 대한 낮은 결합 특성과 복수 고형암에서 확인된 초기 임상 성과를 기반으로 글로벌 기술이전을 추진 중. 바이오마커 기반 환자 선별과 후속 임상 데이터 확보가 주요 경쟁력으로 작용할 전망

이뮨온시아는 CD47 표적 면역항암제 IMC-002의 기술적 차별성과 임상 성과를 기반으로 글로벌 기술이전을 추진하고 있다. CD47 표적 치료제는 대식세포의 암세포 제거 기능을 활성화하는 약물로, 기존 PD-(L)1 계열 면역항암제와 다른 작용기전을 보유하고 있다. 다만 선발 CD47 항체들은 적혈구 등 정상 혈액세포와의 결합에 따른 혈액독성과 임상 유효성 확보의 어려움으로 개발이 중단되는 사례가 발생하였다. 동사는 이러한 한계를 개선하기 위해 정상 혈액세포에 대한 결합을 줄인 IMC-002를 개발하였으며, 현재 간세포암(HCC), 삼중음성유방암(TNBC), 담도암(BTC) 등 고형암을 대상으로 임상 1b상을 진행하고 있다.

IMC-002의 기술적 차별성은 기존 CD47 항체와 다른 항원결합부위(Epitope)를 인식하도록 설계됐다는 점이다. 동사의 비임상 연구에서는 IMC-002가 암세포에 결합하는 반면, 적혈구 등 정상 혈액세포에 대한 결합은 낮은 것으로 확인되었다. 2026년 미국암연구학회(AACR)에서는 항체의 결합 위치와 각도 차이가 적혈구 응집 가능성을 낮출 수 있다는 결합구조 분석 결과를 발표하였다. 또한 임상 1a상에서는 최대 30mg/kg 투여 용량까지 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않았다. 다만 2026년 공개된 삼중음성유방암 임상에서는 3등급(Grade 3) 빈혈 및 용혈성 빈혈이 보고되어 혈액독성이 완전히 해소됐다고 판단하기는 어렵다. 따라서 향후 임상에서 안전성 결과가 일관되게 확인되는 것이 기존 CD47 항체와의 경쟁력을 확보하는 데 중요할 전망이다.

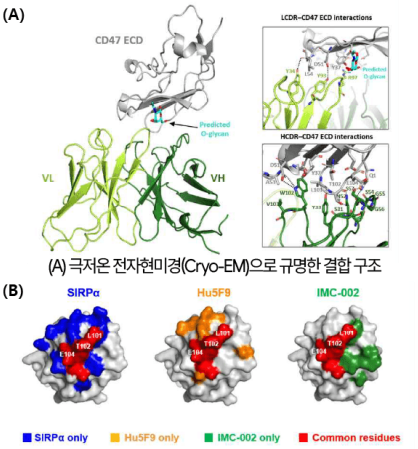
임상 유효성 측면에서는 복수의 고형암에서 초기 항종양 효과가 확인되고 있다. 2025년 미국임상종양학회(ASCO)에서 발표한 간세포암 대상 IMC-002와 렌바티닙 병용요법의 객관적반응률(ORR)은 30%, 질병통제기간은 8.3개월을 기록하였다. 특히 루닛(Lunit)과 공동 수행한 탐색적 바이오마커 분석에서는 CD47의 암세포막 발현 수준이 높은 환자군에서 ORR 60%, 질병통제율(DCR) 80%가 보고되었다. 해당 분석은 평가 가능한 환자 12명을 대상으로 수행된 초기 연구이지만, 바이오마커를 활용해 치료 반응 가능성이 높은 환자군을 선별할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 이어 2026년 ASCO에서 공개된 삼중음성유방암 임상 1b상에서는 IMC-002와 항암화학요법 병용 시 ORR 25%, DCR 75%, 임상적 이득률(CBR) 42%를 기록하였다. 특히 3차 이상 치료 경험이 있는 환자가 전체의 92%를 차지해 치료 선택지가 제한적인 환자군에서 유효성 신호가 관찰됐다는 점은 긍정적이다. 다만 모두 소규모 병용요법 임상 결과인 만큼 IMC-002의 독립적인 치료 효과와 바이오마커 선별 전략의 유효성은 후속 임상에서 추가 검증이 필요하다.

동사는 이러한 임상 성과를 바탕으로 IMC-002의 글로벌 기술이전을 추진하고 있다. 2021년 중국 3D메디슨(3D Medicines)에 중국 지역 개발·상업화 권리를 기술이전하며 사업화 경험을 확보하였으나, 현지 개발 일정이 조정되면서 후속 마일스톤 수령은 지연되고 있다. 현재는 미국과 유럽 등 중국 외 시장을 대상으로 추가 기술이전을 추진하고 있으며, 복수의 고형암에서 임상적 개념증명(PoC, Proof of Concept)을 확보하는 데 주력하고 있다. 2026년 8월에는 췌장암(PDAC) 코호트 추가에 대한 임상시험계획 변경 승인을 획득하였으며, 2027년 4월 AACR(미국 암연구학회)에서 추가 병용 임상 결과 발표를 추진할 계획이다. 향후 다양한 암종에서 유효성 및 안전성 데이터가 축적되고 바이오마커 기반 환자 선별 전략의 가능성이 확인될 경우 글로벌 기술이전 협상력이 높아질 것으로 기대된다. 특히 후속 임상에서 일관된 항종양 효과와 관리 가능한 안전성을 입증하는 것이 IMC-002의 사업화 가치를 결정하는 핵심 요인으로 판단된다.

2026 AACR 발표: 결합 기전 및 적혈구 응집 비유발 기전 규명

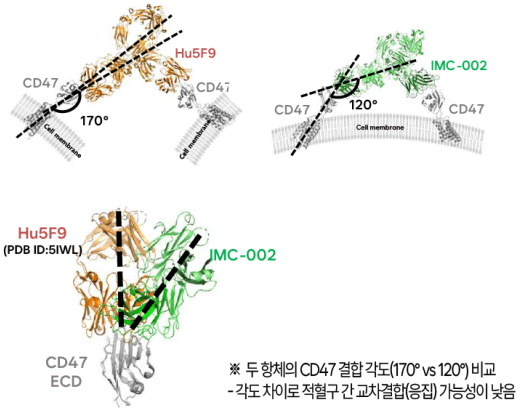
결합 기전 분석

IMC-002는 Hu5F9(마그롤리맙)과 구별되는 CD47 부위에 결합하여 CD47–SIRPα 상호작용을 차단하며, 결합 부위 인근에 잠재적 O-glycosylation site 가 존재하는 것으로 예측됨



적혈구 응집 비유발 기전:

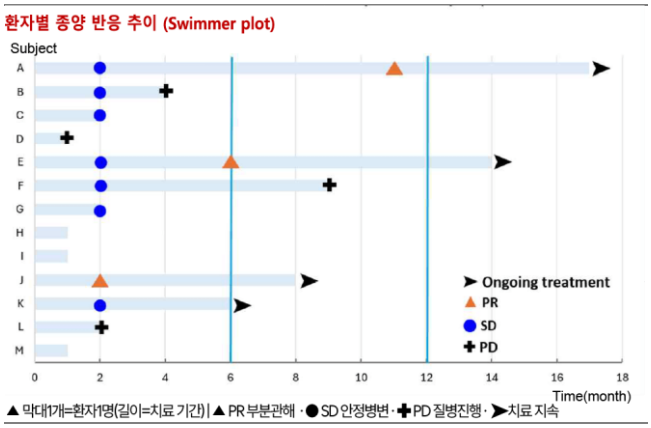
IMC-002의 상이한 결합 부위와 결합 각도가 적혈구 간 교차결합을 제한하여 적혈구 응집 가능성을 낮추는 것으로 추정됨.



※ 두 항체의 CD47 결합 각도(170° vs 120°) 비교
- 각도 차이로 적혈구 간 교차결합(응집) 가능성이 낮음

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

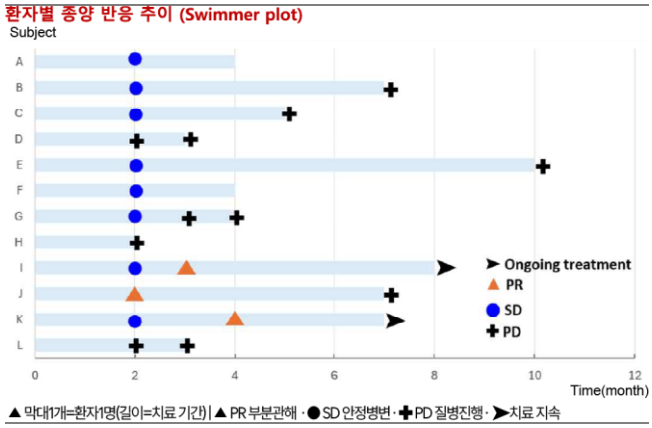
간세포암(HCC) 2차 이상 치료 병용요법 결과



▲ 막대1개=환자1명(길이=치료 기간) | ▲ PR 부분관해 · ● SD 안정병변 · ✚ PD 질병진행 · ➤ 치료 지속

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

삼중음성유방암(TNBC) 2차 이상 치료 병용요법 결과



▲ 막대1개=환자1명(길이=치료 기간) | ▲ PR 부분관해 · ● SD 안정병변 · ✚ PD 질병진행 · ➤ 치료 지속

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 생산·유통 협력체계 구축 및 자금 확보로 상용화 기반 강화

글로벌 CDMO 론자와 유한양행을 통한 생산·유통 협력체계를 구축하고, 약 818억원의 유상증자로 상용화 자금을 확보하며 IMC-001의 국내 출시 준비를 본격화

이뮨온시아는 핵심 파이프라인인 IMC-001의 국내 상용화를 위해 생산·유통 협력체계를 구축하고 있다. 신약은 임상시험을 통해 유효성과 안전성을 확인하더라도 실제 제품 출시를 위해서는 규제기관의 기준을 충족하는 제조공정과 안정적인 공급망 확보가 필수적이다. 동사는 자체 생산시설을 구축하는 대신 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업과의 협력을 통해 상업생산 기반을 확보하는 전략을 채택하였다. 2026년 3월에는 글로벌 CDMO 기업 론자(Lonza)와 IMC-001의 개발·생산 협력계약을 체결하였으며, 이를 통해 임상개발 중심의 사업구조에서 신약 상용화를 준비하는 단계로 전환하고 있다.

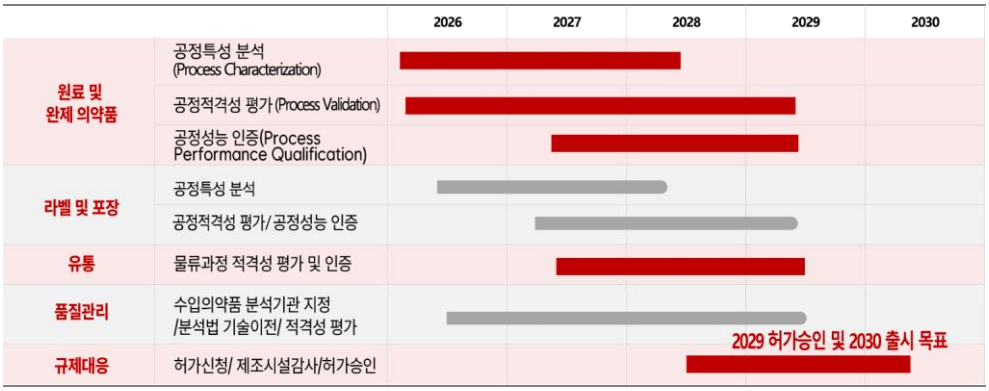
론자는 IMC-001의 원료의약품(DS)과 완제의약품(DP)의 공정개발 및 생산을 담당하며, 동사는 2029년 품목허가 신청과 2030년 국내 출시를 목표로 상업생산 준비를 진행하고 있다. 현재 생산공정 최적화와 품질검증을 추진하고 있으

며, 향후 공정성능적격성평가(PPQ)를 통해 상업생산 공정의 일관성을 검증할 계획이다. 이와 함께 완제의약품의 라벨링·포장, 물류 및 품질관리 체계도 단계적으로 구축하고 있다. 글로벌 CDMO의 생산설비와 공정개발 역량을 활용함으로써 자체 생산시설에 대한 투자 부담을 줄이면서 신약 상용화에 필요한 제조 기반을 마련할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

국내 판매 및 유통은 최대주주인 유한양행과의 협력을 통해 추진할 계획이다. 양사는 IMC-001에 대한 국내 독점 유통계약을 체결하였으며, 이에 따라 이뮨온시아는 임상개발과 품목허가를 담당하고 유한양행은 약가·급여 등재, 영업·마케팅 및 재고관리 등을 수행하는 역할 분담 구조를 마련하였다. 유한양행은 항암신약 렉라자의 국내 출시 경험과 기존 의약품 사업을 통해 확보한 영업·유통망을 보유하고 있다. 동사는 이러한 사업화 역량을 활용해 별도의 대규모 판매조직 구축에 따른 부담을 줄이고 국내 시장 진입의 효율성을 높일 수 있을 것으로 예상된다.

상용화에 필요한 자금도 선제적으로 확보하였다. 동사는 2026년 5월 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 통해 약 818억원을 조달하였으며, 조달자금의 대부분을 IMC-001의 생산공정 개발 및 검증, 품질관리 등 상용화 준비에 투입할 계획이다. 이는 기존 연구개발 중심의 자금 운용에서 벗어나 실제 신약 출시를 위한 제조·품질관리 체계 구축에 본격적으로 투자한다는 점에서 의미가 있다. 동사는 글로벌 CDMO의 생산 역량과 유한양행의 국내 유통망을 활용하고, 상용화에 필요한 재원을 확보함으로써 신약 출시를 위한 사업적 기반을 강화하고 있다. 향후 제조공정 검증과 품목허가 준비가 계획대로 진행될 경우 IMC-001의 국내 상용화 가시성이 높아질 것으로 판단된다.

IMC-001 상용화 계획



자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1 2025년 실적 추이

IMC-001 임상 2상 CSR 완료, IMC-002 간세포암 임상 성과 확보

이뮨온시아의 2025년 실적은 매출액 1.1억원(-83.0% YoY), 영업손실 280억원(전년 126억원), 당기순손실 274억원(전년 57억원)을 기록하였다. 매출은 연구용역 수익 일부가 반영되었으며, 신규 기술이전 계약금 및 개발 단계별 마일스톤 수익이 발생하지 않으면서 외형은 전년 대비 감소하였다. 반면 주요 파이프라인의 임상개발과 상용화 준비를 위한 연구개발비가 확대되면서 영업손실 규모는 증가하였다.

2025년 영업비용은 281억원으로 전년 133억원 대비 크게 증가하였으며, 이 중 연구개발비는 198억원으로 전년 74억원 대비 약 168% 증가하였다. 핵심 파이프라인의 임상개발 및 후속 연구개발에 대한 투자가 확대됨에 따라, 연구개발비 증가가 연간 영업손실 확대의 주된 요인으로 작용하였다. 신약개발기업은 제품 상용화 또는 기술이전 수익이 본격화되기 전까지 연구개발비가 선행적으로 발생하는 특성이 있어, 단기 손익보다는 연구개발 투자에 따른 임상 성과와 사업화 가능성을 함께 평가할 필요가 있다.

2025년에는 핵심 파이프라인의 임상 성과가 구체화되었다. IMC-001은 재발성·불응성 NK/T세포림프종 대상 임상 2상의 임상결과보고서(CSR)를 7월 완료하면서 국내 품목허가 추진을 위한 임상 자료를 확보하였다. 또한 유럽종양학회(ESMO)에서 위암·식도암·간세포암 대상 수술 전 선행요법을 평가한 NeoChance 임상 2상 결과를 발표하였으며, 미국혈액학회(ASH)에서는 NK/T세포림프종 환자의 치료 반응을 예측하기 위한 AI 기반 바이오마커 분석 결과를 공개하였다. 이러한 연구 성과는 IMC-001의 국내 상용화뿐 아니라 향후 적응증 확대 및 환자 선별 전략을 구체화하는 기반으로 평가된다.

IMC-002도 고형암 대상 임상개발을 통해 유효성 및 안전성 관련 데이터를 축적하였다. 동사는 2025년 미국암연구학회(AACR)에서 개선된 항체 결합 특성에 관한 비임상 연구 결과를 발표하였으며, 미국임상종양학회(ASCO)에서는 간세포암 환자 대상 렌바티닙 병용요법의 초기 임상 결과를 공개하였다. 이어 ESMO에서는 정상 혈액세포에 대한 결합을 줄이기 위한 항체 설계와 임상 안전성 관련 연구 결과를 발표하였다. 이와 함께 이중항체 IMC-201의 비임상 개발도 지속하였다.

2 2026년 실적 추이 및 전망

IMC-001 상용화 준비 본격화 및 IMC-002 임상 성과 확대. 2026년 5월 818억원 유상증자로 재원 확보

이뮨온시아의 2026년 상반기 실적은 매출액 0.2억원, 영업손실 100억원(전년동기 78억원), 당기순손실 95억원(전년동기 76억원)을 기록하였다. 신규 기술이전 계약금 및 기존 기술이전 계약에 따른 마일스톤 수익이 발생하지 않으면서 매출은 없었으나, 주요 파이프라인의 임상개발과 상용화 준비를 위한 연구개발비 증가로 영업손실 규모가 확대되었다. 다만 2026년 5월 약 818억원의 유상증자를 통해 IMC-001의 상용화 준비에 필요한 재원을 확보하면서 연구개발과 생산공정 개발을 지속할 수 있는 재무적 여력을 확충하였다.

2026년 상반기 영업비용은 100억원으로 전년동기 80억원 대비 약 26% 증가하였다. 특히 연구개발비는 74억원으

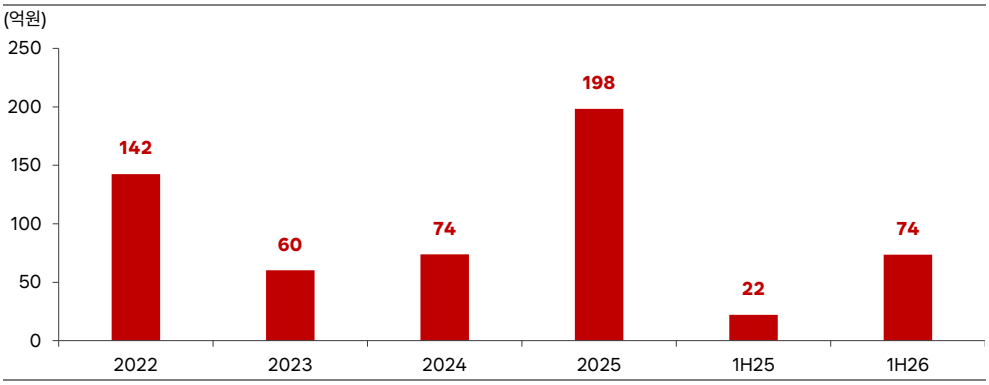
로 전년동기 22억원 대비 크게 증가하였으며, 하반기에도 IMC-001의 상업생산을 위한 공정개발 및 품질검증, IMC-002의 고형암 대상 임상 1b상, IMC-201의 비임상 개발 등이 진행되면서 연구개발 관련 지출은 지속될 전망이다. 특히 2026년부터 본격화된 IMC-001의 상용화 준비는 기존 임상개발 중심의 비용 구조에 상업생산을 위한 제조·품질관리(CMC) 관련 비용이 추가되는 과정이라는 점에서 주목할 필요가 있다.

2026년에는 주요 파이프라인의 임상개발과 상용화 준비에서도 진전이 나타났다. IMC-001은 1월 국내 희귀의약품 지정을 획득하였으며, 3월 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업 론자(Lonza)와 개발·생산 협력계약을 체결하면서 상업생산 준비를 본격화하였다. 또한 7월에는 수술 전 선행요법을 평가한 NeoChance 임상 2상 연구 결과가 논문으로 게재되었으며, 8월에는 NK/T세포림프종 대상 DISTINKT 임상 2상 결과가 국제학술지 British Journal of Haematology에 게재되었다. 이는 임상 유효성에 관한 연구 결과가 축적되는 가운데 품목허가 및 상용화에 필요한 후속 개발이 병행되고 있음을 보여준다.

IMC-002는 2026년 4월 AACR에서 항체 결합구조 분석 결과를 발표하며 기존 CD47 항체와의 기술적 차별성을 뒷받침하는 연구 성과를 확보하였다. 이어 5월 ASCO에서는 삼중음성유방암 대상 임상 1b상 결과를 공개하였으며, 8월에는 췌장암 코호트 추가에 대한 임상시험계획 변경 승인을 획득해 개발 대상 암종을 확대하였다. 이중항체 IMC-201 역시 비임상 개발을 지속하는 가운데 9월 일본 특허 등록을 완료하였다. 동사는 이러한 임상 및 연구 성과를 기반으로 글로벌 제약사와의 기술이전 협상을 추진하고 있다. 특히 2026년에는 IMC-001의 상용화 준비와 IMC-002의 고형암 임상 성과 확보가 주요 연구개발 활동으로 진행되고 있다는 점에서 의미가 있다.

2026년 연간 영업손실은 301억원(전년 280억원), 당기순손실은 290억원(전년 274억원)으로 추정한다. IMC-001의 상용화 준비와 주요 파이프라인의 후속 임상개발에 따른 연구개발비 지출이 지속되는 반면, 기술이전 수익의 발생 시점은 불확실해 연간 적자 기조가 이어질 전망이다. 동사는 IMC-001의 상업생산 공정개발을 본격적으로 추진하고 있으며, IMC-002와 IMC-201의 후속 개발도 이어갈 계획이다. 이에 따라 연구개발 및 상용화 관련 비용 부담이 지속되는 가운데 신규 기술이전 계약이나 기존 계약의 마일스톤 수익이 발생하지 않을 경우 영업손실이 이어질 것으로 예상된다. 다만 임상개발 진전에 따른 기술이전 계약 체결 시점과 계약금 규모는 예측하기 어려워 관련 수익을 확정적으로 반영하기에는 불확실성이 존재한다. 따라서 단기 손익 개선 여부보다는 IMC-001의 제조공정 개발 및 품목허가 준비, IMC-002의 추가 임상 데이터 확보와 글로벌 기술이전 추진 성과가 향후 기업가치를 결정하는 주요 요인으로 판단된다.

경상연구개발비 추이



주: 1H25 경상연구개발비는 2025년 반기보고서 기준

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망 (단위: 억원, %)

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	**77**	**1**	**7**	**1**	**0**
증가율 (%)	21,413.6	-98.6	495.0	-83.0	**-83.0**
영업이익	**-151**	**-118**	**-126**	**-280**	**-301**
세전계속사업이익	**-35**	**89**	**-57**	**-274**	**-290**
당기순이익	**-35**	**89**	**-57**	**-274**	**-290**

자료: 이뮨온시아, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

1 IMC-001 상용화 가치와 IMC-002 기술이전 잠재력에 주목

PD-L1, CD47 유사 파이프라인의 글로벌 기술이전 및 M&A 사례를 고려할 때, IMC-001의 국내 상용화 진전과 IMC-002의 글로벌 기술이전 성과가 기업가치 재평가의 핵심 요인

이뮨온시아는 신약 상용화 이전 단계로 매출 규모가 제한적이고 연구개발비 지출에 따른 영업손실이 지속되고 있어 PER, PBR 등 일반적인 재무지표를 통한 기업가치 평가에는 한계가 있다. 따라서 보유 파이프라인의 임상개발 단계와 유사 신약의 기술이전 및 M&A 사례를 중심으로 기업가치를 평가할 필요가 있다. 2026년 10월 23일 종가 2,925원 기준 동사의 시가총액은 약 2,674억원이다. 동사의 기업가치는 임상개발이 가장 앞선 IMC-001의 국내 상용화 가능성을 기반으로 평가하되, IMC-002의 글로벌 기술이전 잠재력과 후속 파이프라인의 개발 성과를 추가적인 가치 상승 요인으로 고려하는 것이 적절하다고 판단된다.

IMC-001의 기업가치를 평가할 때 참고할 수 있는 대표적인 사례는 중국 씨스톤파마슈티컬스(CStone Pharmaceuticals)의 PD-L1 항체 수게말리맙(Sugemalimab)이다. 수게말리맙은 IMC-001과 동일한 PD-L1 표적 항체로, 재발성·불응성 NK/T세포림프종 대상 임상 2상에서 객관적반응률(ORR) 44.9%, 완전반응률(CR) 35.9%를 기록하였으며, 해당 결과를 기반으로 2023년 10월 중국에서 품목허가를 획득하였다. 이후 2024년 5월 유럽 제약사 에보파마(Ewopharma)에 중·동부 유럽 18개국 및 스위스의 상업화 권리를 이전하는 계약을 체결하였으며, 계약금과 조건부 마일스톤을 포함해 최대 5,130만달러를 수령할 수 있는 구조다. 특히 씨스톤이 의약품 공급을 담당하고 에보파마가 현지 판매·유통을 수행한다는 점에서 이뮨온시아가 추진하는 기술이전 및 의약품 공급 결합 모델과 유사하다. 다만 수게말리맙은 계약 당시 중국에서 이미 복수 적응증에 대한 품목허가를 확보한 상태였으며, 계약 대상 지역도 일부 유럽 국가에 한정되어 있어 개발 단계와 권리 범위의 차이를 고려할 필요가 있다.

PD-L1 항체 개발기업의 M&A 사례도 참고할 수 있다. 인도 선파마(Sun Pharma)는 2025년 3월 미국 체크포인트테라퓨틱스(Checkpoint Therapeutics)를 최대 3억 5,500만달러의 선급 인수대금으로 인수하는 계약을 체결하고, 같은 해 5월 인수를 완료하였다. 체크포인트테라퓨틱스는 PD-L1 항체 코시벨리맙(Cosibelimab)을 개발한 기업으로, 2024년 12월 미국 FDA로부터 진행성 피부편평세포암(cSCC)에 대한 품목허가를 획득하였다. 이는 글로벌 블록버스터가 경쟁하는 대규모 암종이 아니더라도 미충족 의료 수요가 높은 특정 적응증에서 임상적 가치를 확보하고 상용화에 성공할 경우 상당한 기업가치를 인정받을 수 있음을 보여주는 사례다. 이뮨온시아 역시 NK/T세포림프종 임상 2상을 완료하고 국내 희귀의약품 지정을 획득하였다는 점에서 유사한 사업화 전략을 추진하고 있다. 다만 체크포인트테라퓨틱스는 인수 당시 미국 품목허가를 이미 확보한 기업으로, 아직 허가 이전 단계인 이뮨온시아와 직접적인 기업가치 비교에는 한계가 있다.

IMC-002의 글로벌 기술이전 잠재력도 추가적인 기업가치 평가 요인이다. 글로벌 CD47 표적 치료제는 초기 임상 단계에서도 대규모 거래가 이루어진 사례가 있다. 2020년 길리어드사이언스(Gilead Sciences)는 CD47 항체 매그롤리맙(Magrolimab)을 보유한 포티세븐(Forty Seven)을 약 49억달러에 인수하였으며, 2021년 화이자(Pfizer)는 CD47·SIRPα 경로를 표적으로 하는 치료제를 개발하던 트릴리움테라퓨틱스(Trillium Therapeutics)를 약 22억달러에 인수하였다. 또한 2020년 애브비(AbbVie)는 중국 아이맵(I-Mab)의 CD47 항체 렘조팔리맙(Lemzoparlimab)의 중

화권 외 권리를 도입하면서 계약금 1억 8,000만달러를 지급하였다. 동사 역시 2021년 IMC-002의 중화권 권리를 약 4.7억달러 규모로 기술이전한 이력이 있으며, 현재 고형암 대상 임상 1b상에서 확보한 초기 유효성 및 안전성 데이터를 기반으로 글로벌 기술이전을 추진하고 있다. 다만 앞선 CD47 계열 약물들은 이후 임상개발 중단이나 기술이전 계약 종료 등의 사례가 발생한 만큼 과거 거래금액을 현재 가치에 직접 적용하기는 어렵다. 향후 IMC-002의 후속 임상에서 유효성과 안전성이 추가 검증될 경우 글로벌 기술이전 가능성이 높아질 것으로 판단된다.

종합하면 동사의 기업가치는 IMC-001의 국내 상용화 가능성을 기반으로 IMC-002의 글로벌 기술이전 잠재력이 더해지는 구조로 평가할 수 있다. IMC-001은 NK/T세포림프종 임상 2상 완료 이후 품목허가 및 상업생산 준비를 진행하고 있어 향후 사업화 진전에 따른 가치 상승을 기대할 수 있으며, TMB-High 고형암으로 적응증을 확대하고 있다는 점에서도 성장 가능성이 존재한다. IMC-002는 기존 CD47 항체와 차별화된 결합 특성과 고형암 대상 초기 임상 성과를 확보하면서 글로벌 기술이전을 추진하고 있으며, 이중항체 IMC-201 역시 중장기 파이프라인 가치 확대 요인으로 평가된다. 과거 유사 파이프라인의 거래사례를 고려하면 임상 성과와 사업화 가능성이 검증되는 과정에서 추가적인 기업가치 재평가가 가능할 것으로 판단된다. 다만 개발 단계와 적응증, 기술이전 권리 범위에 따라 거래가치에 차이가 발생하는 만큼 단순 비교에 따른 저평가 판단은 적절하지 않다. 향후 IMC-001의 품목허가 절차 진전과 TMB-High 고형암 임상 결과, IMC-002의 추가 임상 성과 및 글로벌 기술이전 여부가 기업가치 재평가의 주요 변수로 작용할 전망이다.

기업가치 평가를 위한 글로벌 비교사례

구분	기업 및 파이프라인	당시 개발 단계 및 거래 내용	거래 규모
PD-L1	CStone / Sugemalimab	NK/T세포림프종 임상 2상 완료 및 중국 허가. 2024년 유럽 일부 지역 상업화 권리 계약	최대 5,130만달러
PD-L1	Checkpoint / Cosibelimab	2024년 미국 FDA 피부편평세포암 허가. 2025년 Sun Pharma에 인수	최대 3억 5,500만달러 선급 인수대금
CD47	I-Mab / Lemzoparlimab(주2)	임상 1상 단계에서 2020년 AbbVie에 중화권 외 권리 기술이전	계약금 1억 8,000만달러
CD47	Forty Seven / Magrolimab(주3)	혈액암 대상 임상 1b상 단계에서 Gilead에 인수	약 49억달러
CD47	Trillium / TTI-621·622(주4)	임상 1b/2상 단계에서 Pfizer에 인수	약 22억달러

주: 1) 거래금액은 권리지역 및 조건이 서로 다르며, CD47 관련 일부 거래는 이후 개발 중단 또는 계약 종료로 이어짐, 2) I-Mab의 Lemzoparlimab은 AbbVie의 개발 전략 변경으로 2023년 기술이전 계약 종료
3) Forty Seven의 Magrolimab은 임상 3상에서 유효성 부족 및 사망 위험 증가로 2024년 혈액암 대상 개발 중단, 4) Trillium의 TTI-622는 2026년 Pfizer의 개발 중단 결정
자료: CStone, Sun Pharma, AbbVie, Gilead Sciences, Pfizer 공식 발표 참조, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인

1 상용화 비용 증가 및 기술이전 지연에 따른 재무 부담 가능성

IMC-001의 상용화 과정에서 추가 비용이 발생하거나 주요 파이프라인의 기술이전 수익이 지연될 경우, 추가 자금조달에 따른 재무 부담 및 주주가치 희석 가능성이 존재

이뮨온시아는 신약 상용화 이전 단계로 매출 규모가 제한적인 가운데, 주요 파이프라인의 임상개발 및 상용화 준비에 따른 연구개발비 지출이 지속되고 있다. 특히 IMC-001의 국내 상용화를 위한 제조공정 개발 및 품질관리 비용은 당초 예상보다 증가하였다. 동사가 2025년 코스닥 상장 당시 추정한 IMC-001의 상용화 관련 제조·품질관리(CMC) 비용은 약 429억원이었으나, 2026년 유상증자 투자설명서에서는 약 790억원으로 확대되었다. 이는 상용화 일정의 조기 추진과 공정개발 계획의 구체화, 물가 및 환율 변동 등에 따른 것으로, 향후에도 추가 비용이 발생할 가능성이 존재한다.

특히 IMC-001은 임상 2상을 완료하였으나 실제 제품 출시까지는 상업생산을 위한 공정검증과 품목허가 절차가 남아 있다. 항체의약품은 생산공정의 일관성과 품질 확보가 중요하며, 공정성능적격성평가(PPQ)에서 요구되는 품질 기준을 충족하지 못할 경우 추가 시험과 공정개발이 필요할 수 있다. 또한 규제기관의 자료 보완 요구나 제조시설 실사 과정에서 일정이 지연될 가능성도 있다. 이 경우 상용화 관련 비용 증가와 함께 제품 출시 및 매출 발생 시점이 늦춰질 수 있으며, 이미 투입된 연구개발비의 회수 가능성도 낮아질 수 있다.

기술이전 수익의 불확실성도 주요 위험요인이다. 동사는 IMC-001·002·201의 해외 기술이전과 기존 계약의 마일스톤 수령을 주요 수익원으로 계획하고 있으나, 실제 계약 체결과 수익 발생 시점은 임상 결과 및 파트너사의 개발 전략에 따라 달라질 수 있다. 특히 2021년 IMC-002의 중화권 권리를 기술이전한 중국 3D메디슨(3D Medicines)은 내부 개발계획을 조정하면서 후속 임상 진입을 지연하였으며, 이에 따라 당초 예상했던 마일스톤 수익도 발생하지 않았다. 향후 신규 기술이전이 지연되거나 기존 계약의 후속 마일스톤 수령이 늦춰질 경우 예상 현금유입이 감소하고 영업손실이 지속될 가능성이 있다.

이러한 상황이 장기화될 경우 추가 자금조달에 따른 주주가치 희석 가능성도 고려해야 한다. 동사는 2026년 5월 약 818억원의 유상증자를 통해 상용화 자금을 확보하였으나, 지속적인 연구개발 및 상업생산 준비에 상당한 자금이 소요될 전망이다. 특히 2026년 5월 투자설명서에서는 계획한 기술이전 수익이 발생하지 않거나 지연되는 경우 2028년 약 500억원 규모의 추가 자금조달을 검토할 수 있다고 제시하였다. 이는 회사가 가정한 시나리오로 실제 자금조달 시점과 규모는 향후 사업 진행 상황에 따라 달라질 수 있다. 다만 향후 신주 발행이나 주식연계채권을 통한 자금조달이 이루어질 경우 기존 주주의 지분 희석과 주가 부담으로 이어질 수 있어, 주요 파이프라인의 개발 일정과 기술이전 성과, 현금흐름에 대한 지속적인 점검이 필요하다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	77	1	7	1	0
증가율(%)	21,413.6	-98.6	495.0	-83.0	-83.0
매출원가	0	0	0	0	0
매출원가율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
매출총이익	77	1	7	1	0
매출이익률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
판매관리비	228	119	133	281	301
판관비율(%)	296.1	11,900.0	1,900.0	28,100.0	N/A
EBITDA	-140	-108	-115	-271	-292
EBITDA 이익률(%)	-180.9	-9,787.7	-1,764.2	-24,381.3	-154,383.1
증가율(%)	적지	적지	적지	적지	적지
영업이익	-151	-118	-126	-280	-301
영업이익률(%)	-194.9	-10,724.5	-1,924.8	-25,182.0	-159,285.3
증가율(%)	적지	적지	적지	적지	적지
영업외손익	116	207	69	6	11
금융수익	0	8	7	7	20
금융비용	0	0	0	0	8
기타영업외손익	116	199	62	-1	-1
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	-35	89	-57	-274	-290
증가율(%)	적지	흑전	적전	적지	적지
법인세비용	0	0	0	0	0
계속사업이익	-35	89	-57	-274	-290
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-35	89	-57	-274	-290
당기순이익률(%)	-45.2	8,058.2	-868.9	-24,605.1	-153,512.1
증가율(%)	적지	흑전	적전	적지	적지
지배주주지분 순이익	-35	89	-57	-274	-290

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	290	266	199	265	799
현금성자산	267	210	82	82	643
단기투자자산	0	50	31	152	100
매출채권	6	0	4	0	0
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	16	7	81	31	56
비유동자산	67	72	63	66	57
유형자산	4	7	4	5	1
무형자산	60	54	49	45	40
투자자산	0	0	0	0	0
기타비유동자산	3	11	10	16	16
자산총계	357	338	262	331	856
유동부채	38	676	65	43	43
단기차입금	0	0	0	0	0
매입채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	38	676	65	43	43
비유동부채	843	3	3	5	1
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	843	3	3	5	1
부채총계	881	680	68	47	44
지배주주지분	-524	-342	194	284	812
자본금	261	269	364	371	455
자본잉여금	280	353	790	1,158	1,891
자본조정 등	73	86	148	137	137
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	-1,139	-1,050	-1,107	-1,381	-1,671
자본총계	-524	-342	194	284	812

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	-153	-83	-147	-228	-309
당기순이익	-35	89	-57	-274	-290
유형자산 상각비	5	5	5	3	4
무형자산 상각비	6	6	6	6	5
외환손익	1	0	0	0	0
운전자본의감소(증가)	-61	1	-50	36	-28
기타	-69	-184	-51	1	0
투자활동으로인한현금흐름	59	-53	17	-131	52
투자자산의 감소(증가)	0	0	0	0	0
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-0	-4	-1	-3	0
기타	59	-49	18	-128	52
재무활동으로인한현금흐름	-2	79	2	359	817
차입금의 증가(감소)	0	0	0	0	-0
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	80	0	10	818
배당금	0	0	0	0	0
기타	-2	-1	2	349	-1
기타현금흐름	0	0	0	0	0
현금의증가(감소)	-96	-58	-127	0	560
기초현금	363	267	210	82	82
기말현금	267	210	82	82	643

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P/B(배)	N/A	N/A	N/A	35.2	3.3
P/S(배)	N/A	N/A	N/A	8,913.9	13,462.5
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
EPS(원)	-47	119	-74	-346	-335
BPS(원)	-701	-448	248	356	888
SPS(원)	104	1	9	1	0
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	6.2	-20.5	77.0	-114.4	-52.9
ROA	-8.0	25.5	-19.0	-92.2	-48.9
ROIC	-806.9	-283.4	-233.1	-500.0	-655.1
안정성(%)					
유동비율	752.5	39.4	305.9	622.3	1,853.9
부채비율	-168.1	-198.8	34.9	16.6	5.4
순차입금비율	-109.7	-112.5	-57.8	-82.2	-91.4
이자보상배율	N/A	-3,772.6	-1,819.3	-5,465.4	-10,349.7
활동성(%)					
총자산회전율	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
매출채권회전율	24.4	0.3	3.0	0.5	N/A
재고자산회전율	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
이뮨온시아	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.10.27	이뮨온시아-면역항암 신약, 상용화에 속도를 더하다

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.